

PROPOSTA DE ADESÃO A PLANOS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

CONTRATAÇÃO SUPER SIMPLES
COLETIVO EMPRESARIAL
DE 02 A 29 VIDAS

ANS nº 368253



SEJA BEM-VINDO

Caro beneficiário(a),

É com grande alegria que a Hapvida, um dos maiores sistemas de medicina e odontologia presente nas 5 regiões do país, recebe você. A partir da data de pagamento da primeira mensalidade, você pode começar a utilizar o seu plano, após o cumprimento da carência, que é o período que o consumidor deve aguardar para usufruir da cobertura contratada. Os prazos máximos de carência são:

- **24 horas para urgências e emergências;**
- **Até 180 dias para consultas, exames, internações e cirurgias;**
- **300 dias para parto a termo, se você contratou um plano Hospitalar com Obstetrícia.**

Para ser atendido em qualquer unidade ou prestador, leve sempre um documento oficial com foto (RG) ou certidão de nascimento (para menores de 18 anos que não possuem carteira de identificação com foto, junto com a identidade do responsável).

Você pode ter acesso a sua carteirinha virtual por meio dos nossos canais digitais, no site www.hapvida.com.br, e no Aplicativo Hapvida (para os sistemas Android ou IOS).

A operadora disponibiliza a identificação biométrica e/ou facial do beneficiário em todas as suas unidades. Nesses locais de atendimento, os clientes devem ser reconhecidos pela impressão digital e/ou facial. Vale ressaltar que a sua biometria será cadastrada no ato do seu primeiro atendimento.

Através dos nossos canais você pode consultar a rede de atendimento disponível de acordo com seu tipo de plano.

Além de nossos canais digitais, você também conta com os serviços de atendimento eletivo e urgência, pode também marcar consultas, exames e outros procedimentos nos terminais de autoatendimento (totens) em todas as unidades exclusivas, bem como pelos telefones 4020-1899, 0300 789 3650 e (16) 3434-4780, no horário de 06hs às 22hs.

Informações, reclamações e sugestões:

Site: www.hapvida.com.br/site/central_de_ajuda

SAC (24h): 0800.018.3456

Ouvidoria: 4020.9091 (segunda a sexta, exceto feriado, das 7h às 19h)

Será um prazer cuidar da sua saúde!

 /hapvida.saude

 @hapvidasaude

Apresente sempre um documento de identificação ao utilizar seu plano. Para menores, a Certidão de nascimento e a documentação do responsável legal são obrigatórios.



PROPOSTA CONTRATUAL PLANO COLETIVO

PARA O UNIVERSO DE 02 (DOIS) A 29 (VINTE E NOVE)
Hapvida Assistência Médica SA • Av Heráclito Graça, 406.
Centro. Fortaleza/CE • CEP 60140-060 • CNPJ 63554067/0001-98.

Nº DA PROPOSTA

958843

ANS nº 368253

01 - Dados da Empresa Contratante			Contrato		Tabela	
C.N.P.J	66.693.135/0001-98	CAEPF				
Razão Social	DR MARMORES E GRANITOS LTDA					
Nome Fantasia	DR MARMORES E GRANIT					
Ramo de Atividade			Inscrição Estadual			
02 - Dados Complementares			Endereço de Cobrança ☒ Mesmo ☐ Outros			
Endereço de cobrança			X 42			
Complemento		Bairro	SETOR TOCANTINS	CEP	74921355	
Cidade	APARECIDA DE GOIANIA	UF	GO	Telefone	6232999999	
FAX						
Endereço	X 42					
Complemento		Bairro	SETOR TOCANTINS	CEP	74921355	
Cidade	APARECIDA DE GOIANIA	UF	GO	Telefone	6232999999	
FAX						
03 - Dados do responsável						
Nome do Responsável		CAIO DUARTE DE SOUSA FREITAS				
CPF	070.515.742-10	Cargo	PROPRIETARIO			
Telefone	6232999999	E-mail	DCAIO2905@GMAIL.COM			
04 - Porte da Empresa Conforme o Número de Beneficiários			Porte I: de 02 a 15 usuários ☒ Porte II: de 16 a 29 usuários ☐			
05 - Adesão / Vigência / Vencimento						
Vigência	08/07/2026					
Vencimento	15					
06 - Cálculo do Custo Total do Contrato			☒ Integral Observações:			
Plano de Saúde	R\$ 1.343,52	Plano Odonto	R\$ 139,50	Tx. de Adesão	R\$ 120,00	
Total Geral	R\$ 1.603,02					
07 - Produtos						
ASSISTÊNCIA MÉDICA						

NP QUIRINOPOLIS

Cód. ANS - Saúde	487815209
Cód. Comercial	11162
Nome Comercial	NOSSO PLANO AHO CE GM ENF CC SF 285 M2
Segmentação	AMBULATORIAL + HOSPITALAR + OBSTETRICIA
Acomodação	ENFERMARIA
Fator Moderador	Coparticipação 1/2
Abrangência Geográfica	GRUPO DE MUNICÍPIOS
Área atuação	GOIANIA/GO, ANAPOLIS/GO, APARECIDA DE GOIANIA/GO, QUIRINOPOLIS/GO
Nº de Vidas	6

ODONTOLOGIA

Cód. ANS - Saúde	471904142
Cód. Comercial	9732
Nome Comercial	+ODONTO PREMIUM NACIONAL EMP
Segmentação	ODONTO
Acomodação	SEM ACOMODACAO
Fator Moderador	
Abrangência Geográfica	NACIONAL
Área atuação	
Nº de Vidas	6

08 - Abrangência Geográfica e da Área de Atuação do(s) Plano(s) Contratado(s)

A contratante declara para os devidos fins que, por questões de conveniência, opta por receber correspondências, faturas, notificações e quaisquer informações relacionadas à presente contratação, no endereço informado na presente proposta de adesão e que está ciente de que somente poderá demandar atendimento junto à Operadora contratada no município de celebração da presente proposta ao final informado, bem como nos municípios pertencentes às áreas de abrangência geográfica e de atuação do(s) produto(s) contratado(s), especificados na página de Apresentação de Produtos, parte integrante do Caderno de Proposta, nos termos da RN No. 566/2022, da ANS.

09 - Mecanismos de Regulação Financeira do(s) Plano(s) Contratado(s)

9.1 - Para todo e qualquer produto que envolva a cobertura hospitalar, inclusive aquele elencados como "Sem Coparticipação", a contratante será cobrada, a título de coparticipação, do percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre o custo total das internações psiquiátricas a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia, ininterruptos ou não, a cada ano de contrato, realizadas pelos beneficiários do(s) plano(s) contratado(s).

9.2 - A contratante declara para os devidos fins que, se o(s) produto(s) contratado(s), descrito(s) na página de Apresentação de Produtos de Assistência Médica constante da presente Proposta, prevê a cobrança de COPARTICIPAÇÃO, esta será cobrada conforme disposto na tabela de vendas. Entende-se por COPARTICIPAÇÃO, a importância, além da contraprestação mensal, a ser paga pelo CONTRATANTE diretamente à Operadora, para custeio de parte da despesa de determinado procedimento realizado pelos beneficiários ou seus dependentes. Os pagamentos serão efetuados por meios eletrônicos disponibilizado pela CONTRATADA quando forem realizados na rede própria. Declara, também, que é de seu conhecimento de que, ainda que o contrato preveja a cobrança de Coparticipação, os beneficiário(s) continua(rá)o(s) sujeito(s) ao cumprimento integral dos períodos de carência e de Cobertura Parcial Temporária (CTP) para Doenças ou Lesões Preexistentes (DLP), quando for o caso.

10 - Condições Gerais da Contratação e Contratos Que Regulamentam os Planos Contratados

10.1 - A CONTRATANTE declara ter pleno conhecimento das condições gerais da contratação previstas no Instrumento Jurídico de Contratação de Planos de Assistência Médica e/ou Odontológica Coletivos Empresariais, firmado por ocasião de presente Proposta, bem como de todas as condições estabelecidas nos instrumentos contratuais que regulam os planos contratados, cujas minutas foram recebidas na presente data, através de documentos eletrônicos salvos em mídia digital, declarando-se responsável, ainda, pelo fiel cumprimento das mesmas.

10.2 A CONTRATANTE declina da contratação do plano referência, oferecido pela OPERADORA nos termos da regulamentação vigente.

10.3 A CONTRATADA declara que utiliza os Dados Pessoais constantes nesta proposta para finalidade específica de contratação e operacionalização de Plano de Saúde e/ou Odontológico, em conformidade com a Lei nº 13.709 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

APARECIDA DE GOIANIA, 08 de JULHO de 2026.

Assinatura do(a) CONTRATANTE.

11 - Recibo de pagamento

Recebemos da empresa acima a importância de R\$ R\$ 1.603,02 (UM MIL E SEISCENTOS E TRÊS REAIS E DOIS CENTAVOS),

através de ESPÉCIE relativo ao valor da primeira mensalidade dos planos contratados, módulos opcionais e taxa de adesão por usuário.

Local: APARECIDA DE GOIANIA Data: 08 / 07 / 2026

Assinatura do representante autorizado: _____

12 - Dados do representante

Nome do vendedor:	MORGANA DORNELES DE QUEIROZ	Código:	3534626	
Nome da representação:	VIVAZ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	Código:	5429	Rúbrica:

**CONDIÇÕES GERAIS DO INSTRUMENTO JURÍDICO DE CONTRATAÇÃO DE PLANOS DE
ASSISTÊNCIA À SAÚDE E/OU ODONTOLÓGICA COLETIVOS EMPRESARIAIS – SUPER SIMPLES**
(versão 05.2025.001)

1. QUALIFICAÇÃO DAS PARTES

Pelo presente **INSTRUMENTO JURÍDICO DE CONTRATAÇÃO DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E/OU ODONTOLÓGICA COLETIVOS EMPRESARIAIS – SUPER SIMPLES**, daqui por diante chamado de **INSTRUMENTO** ou **CONTRATO**, de um lado o **HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A**, Operadora de Planos Privados de Assistência à Saúde, com sede na Avenida Heráclito Graça, nº 406, Centro, Fortaleza - Ceará, inscrita no CNPJ sob o nº. 63.554.067/0001-98, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS sob o nº. 36.825-3, classificada como medicina de grupo, neste ato, representada por seus diretores, aqui denominada **CONTRATADA** e, de outro lado, a **EMPRESA** devidamente qualificada e subscrita na **PROPOSTA COMERCIAL**, neste ato representada pelos seus Diretores e doravante denominada **CONTRATANTE** e quando em conjunto, denominadas **PARTES**, têm entre si, justo e livremente contratado, o que se apresenta nas cláusulas a seguir.

2. NATUREZA E DO OBJETO DO CONTRATO

A **CONTRATADA** opera Planos Privados de Assistência à Saúde, Coletivos Empresariais, nos termos do inciso I, do artigo 1º, da Lei nº. 9.656/98 e sua legislação complementar, e se obriga à cobertura dos custos de assistência à saúde dos produtos por ela operados.

O presente **INSTRUMENTO** se reveste de característica de adesão bilateral, gerando direitos e obrigações individuais às partes, na forma do Novo Código Civil Brasileiro, sujeitando-as às normas estabelecidas na Lei nº. 9.656/98 e sua legislação complementar específica ou outra que vier a sucedê-la e, subsidiariamente, às disposições do Código de Defesa do Consumidor, quando for o caso.

O presente **INSTRUMENTO** tem por objeto a prestação continuada de serviços de saúde na segmentação médico-hospitalar e odontológica, na forma de Plano Privado de Assistência à Saúde, conforme previsto no inciso I, art. 1º da Lei nº 9.656/98, visando à cobertura das doenças da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, e do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde editado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, vigente à época do evento.

3. PLANOS CONTRATADOS

O presente **INSTRUMENTO** versa sobre a contratação dos planos/produtos de assistência à saúde, operados pela **CONTRATADA** e devidamente registrados na Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.

Por meio do presente **INSTRUMENTO**, estão sendo disponibilizados os produtos constantes da **PROPOSTA COMERCIAL** e da **TABELA DE PREÇOS**, para **Beneficiários** ativos e inativos.

Todas as características do(s) plano(s) de assistência médica e/ou de assistência odontológica contratado(s), tais como abrangência geográfica, área de atuação, segmentação(ões) assistencial(is), padrão de acomodação e outras, constam discriminadas na **PROPOSTA COMERCIAL**, **Ficha Técnica do(s) Produto(s)**, bem como nas **Condições do(s) Produto(s)**, disponíveis para *download*.

A cobertura dos custos de assistência à saúde estará limitada às características dos produtos contratados parte integrante e indissolúvel do presente **CONTRATO**, que compõem no seu conjunto os direitos aos quais os **Beneficiários** da **CONTRATANTE**, definidos nos termos do presente **INSTRUMENTO**, fazem jus em cada um dos produtos onde vierem a ser regularmente cadastrados junto à **CONTRATADA**, seguindo as condições abaixo descritas:

- a) de acordo com a segmentação assistencial e com os procedimentos previstos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, da ANS, para a(s) segmentação(ões) que compõe(m) cada produto contratado;
- b) de acordo com a abrangência geográfica/área de atuação de cada produto, que delimitam o(s) Estado(s) e/ou Município(s) onde será garantido o atendimento;
- c) de acordo com as demais características individuais de cada produto contratado, incluindo o padrão de acomodação (caso existente no produto), o público-alvo (ativos/inativos), a previsão ou não de mecanismos de regulação financeira, entre outras;

Ressalvados os parâmetros e limites acima expostos, os **Beneficiários** terão direito à assistência médica das afecções à saúde em todas as doenças da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde - OMS e do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, editado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, vigente à época da solicitação de cobertura do evento.

As características e condições específicas de cada produto contratado, encontram-se nas **Condições do(s) Produto(s)**, relativos a cada um dos planos/produtos que fazem parte indissociável deste **INSTRUMENTO**, juntamente com os respectivos Guias de Leitura Contratual – GLC, entregues em mídia eletrônica por ocasião desta contratação, pelo qual a **CONTRATANTE** ora declara o seu recebimento.

4. BENEFICIÁRIOS

São considerados **Beneficiários** das coberturas dos Planos de Assistência à Saúde, objeto deste **INSTRUMENTO** e das **Condições do(s) Produto(s)**, que regulam cada produto contratado: o(s) **Beneficiário(s) Titular(es)** e/ou o(s) **Beneficiário(s) Dependente(s)**, de acordo com o definido abaixo.

4.1. Beneficiários Ativos. Os **Beneficiários Ativos**, abaixo qualificados, serão inscritos nos planos exclusivos para **Ativos** de acordo com os planos contratados.

4.1.1. Beneficiário Ativos Titulares. São aqueles vinculados à **CONTRATANTE** por relação empregatícia ou estatutária, sócios e administradores, agentes políticos, trabalhadores temporários, estagiários e menores aprendizes, devidamente inscritos nos planos do presente **INSTRUMENTO**.

4.1.2. Beneficiários Dependentes de Ativos. São aqueles incluídos pela **CONTRATANTE**, desde que o **Beneficiário Ativo Titular** esteja regularmente inscrito em um dos planos contratados e mantenham com este um dos seguintes vínculos familiares:

- a) O cônjuge ou companheiro(a), desde que comprove esta condição legalmente;
- b) Os(As) filhos(as) do **Titular**, até 53 (cinquenta e três) anos de idade completos;
- c) O(A) enteado(s) do **Titular**, até 53 (cinquenta e três) anos de idade completos;
- d) Filhos inválidos de qualquer idade, mediante comprovação médica e legal da invalidez e dependência econômico-financeira;
- e) Os (As) netos(as) do **Titular**, até 53 (cinquenta e três) anos de idade completos.

4.2. Beneficiários Inativos. Os **Beneficiários Inativos**, abaixo qualificados, poderão ser, a critério da **CONTRATADA**, inscritos nos planos exclusivos para **Inativos** ou permanecerão nos mesmos planos de **Ativos**, nos casos dos produtos constantes na contratação do Plano de Saúde, ou permanecerão nos mesmos produtos nos casos dos produtos constantes na contratação do Plano Odontológico, por ocasião dos direitos previstos nos arts. 30 ou 31, da Lei nº 9.656/98.

4.2.1. Nos planos de assistência à Saúde, ao passarem da categoria de **Ativos** para **Inativos**, os **Beneficiários Titulares** e seus respectivos dependentes, serão transferidos para os planos equivalentes disponíveis exclusivamente para **Inativos**.

4.2.2. Nos planos de assistência Odontológica, ao passarem da categoria de **Ativos** para **Inativos**, os **Beneficiários Titulares** e seus respectivos dependentes, permanecerão no mesmo produto, com aplicação dos benefícios do art. 30 ou 31 da Lei nº 9.656/98.

4.2.3. Beneficiários Inativos Titulares. São os Aposentados ou Demitidos ou Exonerados sem justa causa, que tenham sido vinculados à **CONTRATANTE** anteriormente e somente para fins do exercício do direito previsto nos arts. 30 e 31, da Lei nº 9.656/98 e na regulamentação vigente, bem como os **Beneficiários Ativos Titulares** da **CONTRATANTE** que vierem a se aposentar ou ser demitidos ou exonerados sem justa causa, que se enquadrem na legislação retrocitada, pelos prazos previstos.

4.2.4. Beneficiários Dependentes de Inativos. São os indivíduos que já se encontravam regularmente inscritos no plano oferecido pela **CONTRATANTE** e enquadrados na elegibilidade descrita no item 4.1.2 acima, quando da vigência do contrato de trabalho do **Beneficiário Titular Inativo** com a **CONTRATANTE**, ressalvada, exclusivamente, a possibilidade de inclusão de novo cônjuge ou filhos do ex-empregado nascidos ou adotados após a aposentadoria ou demissão/exoneração sem justa causa, devendo se enquadrar nas seguintes opções:

- a) O cônjuge ou companheiro(a), desde que comprove esta condição legalmente;
- b) Os(As) filhos(as) do **Titular**, até 53 (cinquenta e três) anos de idade completos;
- c) O(A) enteado(a) do **Titular**, até 53 (cinquenta e três) anos de idade completos;
- d) Filhos inválidos de qualquer idade, mediante comprovação médica e legal da invalidez e dependência econômico-financeira;
- e) Os (As) netos(as) do **Titular**, até 53 (cinquenta e três) anos de idade completos.

4.3. Documentação Comprobatória

4.3.1. De acordo com o previsto na legislação, a **CONTRATANTE** deverá comprovar documentalmente, junto à **CONTRATADA**, a elegibilidade dos **Beneficiários** que cadastrar nos planos deste **INSTRUMENTO** por meio do envio dos documentos abaixo elencados, sob pena dos **Beneficiários** não serem efetivados nos respectivos planos.

- a) Cônjuge ou companheiro(a) – certidão de casamento ou escritura pública de união estável;
- b) Filhos naturais ou adotivos e netos – certidão de nascimento ou documento de identidade onde conste o nome de ambos os genitores e os documentos de identidade de todos os ascendentes até que se comprove inequivocamente a relação de parentesco enunciada com o **Titular**, necessários para tanto;
- c) Enteados – certidão de nascimento ou documento de identidade associada à certidão de casamento ou escritura pública de união estável;

d) Filhos inválidos – os mesmos documentos exigíveis aos filhos mais o laudo pericial médico constatando a condição de invalidez e a declaração de dependência econômico-financeira nos termos da Receita Federal.

4.3.2. Fica assegurado à **CONTRATADA** o direito de exigir no ato da assinatura deste **INSTRUMENTO** ou a qualquer tempo, da **CONTRATANTE**, ou mesmo diretamente dos **Beneficiários**, a comprovação da relação funcional ou de dependência, aqui especificada, mediante apresentação dos documentos oficialmente instituídos.

4.3.3. Fica a **CONTRATANTE**, caso constituída como EMPRESÁRIO INDIVIDUAL, nos termos da regulamentação vigente da ANS, obrigada a, anualmente, em até 60 (sessenta) dias da data de aniversário do **CONTRATO**, comprovar perante a **CONTRATADA** a sua regularidade junto à Receita Federal e à Junta Comercial do respectivo Estado/Órgão Competente, bem como o vínculo empregatício dos seus empregados e de parentesco entre estes e seus dependentes, por meio da seguinte documentação:

- a)** Requerimento de Empresário ou Contrato Social registrado na Junta Comercial do respectivo Estado da Federação ou Órgão competente, que esteja em situação ATIVA;
- b)** Comprovante de inscrição emitido junto ao site da Receita Federal que comprove a regularidade cadastral, em situação ATIVA;
- c)** Comprovantes de vínculo empregatício de seus empregados (e-Social, cópia da Ficha de Registro do Empregado ou Cópia da CTPS) e de vínculo de parentesco entre titulares e dependentes, quando a **CONTRATANTE** tiver funcionários a serem incluídos no **CONTRATO** (Certidão de Casamento/Declaração de União Estável e Certidão de Nascimento).

4.4. Regras e Prazos para o cadastramento dos Beneficiários

4.4.1. Cadastramento da massa inicial. O cadastramento da massa inicial será feito por meio de arquivo eletrônico em layout e formato a serem negociados entre as partes, respeitando os requisitos mínimos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS em relação às informações mínimas necessárias para o cadastramento das vidas junto à **CONTRATADA**.

4.4.1.1. O respectivo arquivo deverá ser gerado pela **CONTRATANTE** e uma vez recepcionado pela **CONTRATADA** será submetido às críticas quanto à integridade dos dados enviados.

4.4.1.2. Os dados criticados, com os respectivos apontamentos das críticas encontradas, serão devolvidos para que a **CONTRATANTE** possa proceder ao ajuste das informações requeridas.

4.4.1.3. Alternativamente, o cadastramento da massa inicial poderá ser feito pela **CONTRATANTE** diretamente no site da **CONTRATADA**, na área restrita da **CONTRATANTE**, mediante o uso de usuário e senha fornecidos pela **CONTRATADA** para esta finalidade. Nesta funcionalidade, as críticas aos dados incluídos serão processadas em tempo real, de forma que dados incorretos não serão aceitos e os **Beneficiários** não serão incluídos, eximindo-se a **CONTRATADA** da responsabilidade de oferecer qualquer atendimento aos **Beneficiários**.

4.4.1.4. O prazo para a inclusão da massa inicial com a isenção dos períodos de carência foi negociado entre a **CONTRATANTE** e a **CONTRATADA** e fica fixado em 30 (trinta) dias, contados da data de vigência deste **INSTRUMENTO**.

4.4.2. Movimentação cadastral. A movimentação cadastral, que compreende as inclusões, exclusões e alterações será feita pela **CONTRATANTE** diretamente no site da **CONTRATADA**, na área restrita da **CONTRATANTE**, mediante o uso de nome de usuário e senha de acesso fornecidos pela **CONTRATADA**, exclusivamente, para esta finalidade.

4.4.2.1. Prazos de movimentação cadastral

As inclusões de novos **Beneficiários**, serão promovidas pela **CONTRATANTE** por meio do website da **CONTRATADA**, mediante login e senha próprios:

- a)** Se o vencimento do valor mensal do **CONTRATO** for 05 (cinco) - até o dia 10 (dez) do mês respectivo, apresentando toda a documentação necessária para as inclusões, que ocorrerão a partir do 1º (primeiro) dia do mês subsequente. Os mesmos prazos deverão ser obedecidos nas solicitações de alterações cadastrais dos **Beneficiários**;
- b)** Se o vencimento do valor mensal do **CONTRATO** for qualquer outra data - até o dia 15 (quinze) do mês respectivo, apresentando toda a documentação necessária para as inclusões, que ocorrerão a partir do 1º (primeiro) dia do mês subsequente. Os mesmos prazos deverão ser obedecidos nas solicitações de alterações cadastrais dos **Beneficiários**.

As exclusões dos **Beneficiários Titulares** e **Beneficiários Dependentes** serão promovidas pelo **CONTRATANTE**, por meio do endereço eletrônico da **CONTRATADA**, mediante login e senha próprios:

- a)** Se o vencimento do valor mensal do **CONTRATO** for 05 (cinco) - até o dia 10 (dez) do mês respectivo, apresentando toda a documentação necessária para as exclusões, que ocorrerão a partir do 1º (primeiro) dia do mês subsequente. Os mesmos prazos deverão ser obedecidos nas solicitações de alterações cadastrais dos **Beneficiários**;
- b)** Se o vencimento do valor mensal do **CONTRATO** for qualquer outra data - até o dia 15 (quinze) do mês respectivo, apresentando toda a documentação necessária para as exclusões, que ocorrerão a partir do 1º (primeiro) dia do mês subsequente. Os mesmos prazos deverão ser obedecidos nas solicitações de alterações cadastrais dos **Beneficiários**.

O **Beneficiário Titular** poderá solicitar sua exclusão ou a exclusão de seu(s) dependente(s) à **CONTRATANTE**, a qualquer tempo, devendo observar o que determina o item 4.8 deste **INSTRUMENTO**.

4.4.2.2. Na falta de comunicação, em tempo oportuno, da inclusão ou exclusão de **Beneficiários**, a fatura se baseará nos dados disponíveis, sendo as eventuais retificações implementadas na fatura subsequente.

4.4.2.3. As despesas decorrentes do atendimento de **Beneficiário Titular** e de seus **Dependentes**, que deixou de pertencer aos quadros da **CONTRATANTE**, cuja exclusão não tenha sido imediatamente comunicada à **CONTRATADA**, serão de responsabilidade da **CONTRATANTE**.

4.5. A **CONTRATANTE**, ao solicitar a exclusão de **Beneficiário(s)** do plano privado de assistência à saúde, deverá informar à **CONTRATADA**:

- a)** se o **Beneficiário** foi excluído por demissão ou exoneração sem justa causa ou aposentadoria;
- b)** se o **Beneficiário** contribuía para o pagamento do plano privado de assistência à saúde;
- c)** por quanto tempo o **Beneficiário** contribuiu para o pagamento do plano privado de assistência à saúde; e

d) se o ex-empregado optou pela sua manutenção como **Beneficiário** ou se renunciou o seu direito de continuar na condição de **Beneficiário**.

4.6. Nos termos da regulamentação vigente da ANS, a **CONTRATADA** solicitará à **CONTRATANTE**, sempre que esta última solicitar a exclusão de **Beneficiário**, que lhe seja informado a razão da exclusão, e sendo por demissão/exoneração, sem justa, ou aposentadoria, e só acatará mediante a comprovação de que ele foi comunicado da opção de manutenção da condição de **Beneficiário** de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, bem como das informações previstas no item anterior.

4.7. Uma vez disponibilizadas as ferramentas suficientes para as movimentações cadastrais de qualquer natureza sejam elas: acesso ao site mediante usuário e senha privativos, *layouts* e integrações tecnológicas ou outra qualquer que venha a ser estabelecida e pactuada entre as partes, a **CONTRATANTE** passa a assumir total responsabilidade sobre as movimentações cadastrais dos seus beneficiários que vier a promover. A **CONTRATADA** limitar-se-á, tão somente, a executá-las conforme tenham sido solicitadas e dentro dos prazos pactuados.

4.8. Perda da qualidade de Beneficiário

4.8.1. Nos planos coletivos empresariais caberá à pessoa jurídica contratante solicitar a suspensão ou exclusão de beneficiários, ou outra forma que venha a ser prevista na legislação de saúde, compreendida pela Lei nº 9.656/98 e sua legislação complementar.

4.8.2. Os **Beneficiários** poderão solicitar à **CONTRATANTE** que providencie, junto à **CONTRATADA**, a sua exclusão, dentro do prazo legal.

4.8.3. A exclusão do **Beneficiário Titular**, pela **CONTRATANTE**, seja por decisão desta ou por solicitação do **Beneficiário Titular**, importa na exclusão compulsória de todos os dependentes a ele vinculados.

4.8.4. A **CONTRATADA** poderá excluir ou suspender a assistência à saúde dos **Beneficiários**, sem a anuência da pessoa jurídica contratante, nas seguintes hipóteses:

- a)** fraude;
- b)** por perda dos vínculos do titular com a pessoa jurídica contratante, ou de parentesco, ressalvado o disposto nos artigos 30 e 31, da Lei nº 9656/1998;
- c)** quando os **Beneficiários Dependentes** atingirem a idade máxima estabelecida no **CONTRATO** ou se constatar a desqualificação dos vínculos previamente elencados nos itens 4.1.2 e 4.2.2.
- d)** a exclusão do **Beneficiário Titular**, pela **CONTRATADA**, importa na exclusão compulsória de todos os dependentes a ele vinculados.

4.8.4.1. Se a **CONTRATANTE** for constituída como **EMPRESÁRIO INDIVIDUAL**, nos termos da regulamentação vigente da ANS, ou no caso de **Beneficiário** que efetuar pagamento das mensalidades diretamente à **CONTRATADA**, a **CONTRATADA** deverá promover notificação prévia, observando-se os meios de notificação previstos no item 15.4, para rescisão unilateral ou exclusão do **Beneficiário** do **CONTRATO** por motivo de fraude ou inadimplência.

4.9. Número mínimo de participantes

4.9.1. A **CONTRATANTE** se compromete a manter, em virtude das condições garantidas pela **CONTRATADA**, durante o prazo de vigência deste **CONTRATO**, o número mínimo de 02 (dois) **Beneficiários**, sob pena de rescisão imediata do **CONTRATO**.

4.10. Participação da CONTRATANTE no custeio das contraprestações pecuniárias

4.10.1. A forma de custeio do plano pela **CONTRATANTE** é INTEGRAL, não gerando para os **Beneficiários Ativos** inscritos nos produtos contratados por ocasião do presente **INSTRUMENTO**, os direitos previstos nos arts. 30 e 31, da Lei No. 9.656/98 e RN No. 488/2022, quando vierem a ser demitidos ou exonerados sem justa causa ou aposentados.

4.10.2. No caso de custeio integral pela **CONTRATANTE**, não será considerada contribuição, os valores relacionados aos dependentes e à coparticipação do **Beneficiário** na utilização dos serviços de assistência médica ou hospitalar.

5. COBERTURAS

O presente **INSTRUMENTO** garante aos **Beneficiários** da **CONTRATANTE** as coberturas previstas na Lei nº 9.656/98 e sua legislação complementar de acordo com a segmentação, abrangência geográfica, acomodação e rede assistencial específicos do plano em que forem devidamente cadastrados, observadas as respectivas **Condições do(s) Produto(s)**, parte integrante e indissolúvel do Contrato de Assistência à Saúde, devidamente relacionadas às doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, da Organização Mundial de Saúde – OMS.

O direito às coberturas existirá, uma vez cumpridos os períodos de carência, ou Cobertura Parcial Temporária - CPT, à que os beneficiários estejam sujeitos, bem como respeitadas as exclusões de cobertura previstas nos contratos individualizados de cada plano e no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, da ANS.

Nas **Condições do(s) Produto(s)**, que individualiza cada plano contratado, que fazem parte da documentação anexa ao presente **INSTRUMENTO**, estão detalhados os procedimentos cobertos, suas exclusões, bem como suas demais particularidades.

O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, publicado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, e revisado com a frequência definida por este órgão regulador, traz a relação de todos os procedimentos com cobertura garantida pelos planos contratados, com indicação inclusive das diferentes segmentações (ambulatorial, hospitalar, obstétrica e odontológica) a que cada procedimento pertence, não deixando assim margem para qualquer dúvida. O Rol de Procedimentos em saúde vigente à época da solicitação do evento pode ser encontrado no site da ANS.

O atendimento, dentro da segmentação de cada plano, da área de abrangência e da área de atuação estabelecidas, está assegurado independentemente do local de origem do evento. Ou seja, desde que o **Beneficiário** solicite a realização do procedimento nos municípios onde tem efetivamente assistência.

As coberturas previstas para os produtos elencados serão garantidas exclusivamente por meio da rede informada pela **CONTRATADA** no Manual de Orientação do Beneficiário e no seu site. Excetuando-se os planos registrados com livre escolha de prestadores na ANS, os **Beneficiários** cadastrados nos planos contratados no presente **INSTRUMENTO**, não terão direito à livre escolha de profissional ou mesmo de

prestador pertencente à rede assistencial de outros planos da **CONTRATADA**, que não daquele ao qual estiver devidamente cadastrado.

5.1. Cobertura nos casos de urgência e emergência – produtos de assistência médica

Observadas as segmentações assistenciais previstas nos produtos contratados conforme as suas **Condições do(s) Produto(s)**, é obrigatória por parte da **CONTRATADA** a cobertura dos atendimentos de urgência e emergência, assim considerados:

I - urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional;

II - emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente.

5.1.1. Acidentes pessoais

A **CONTRATADA** garantirá os atendimentos decorrentes de acidentes pessoais, sem restrições, depois de decorridas 24 horas de vigência do **CONTRATO**.

5.1.2. Processo gestacional

A **CONTRATADA** garantirá os atendimentos de urgência e emergência referentes ao processo gestacional, limitados às primeiras 12 (doze) horas, nos planos sem cobertura obstétrica e nos planos com cobertura obstétrica cujos prazos de carência ainda não tenham sido cumpridos pelo **Beneficiário**.

5.1.3. Beneficiário em carência

Nos casos em que os prazos de carência ainda não tenham sido cumpridos pelo **Beneficiário**, os atendimentos de emergência terão cobertura limitada às primeiras 12 (doze) horas ou até que haja necessidade de internação.

5.1.4. Beneficiário em cobertura parcial temporária

Nos casos em que houver acordo de Cobertura Parcial Temporária - CPT e que resultem na necessidade de eventos cirúrgicos, leitos de alta tecnologia ou procedimentos de alta complexidade relacionados às doenças ou lesões preexistentes, a cobertura do atendimento de urgência e emergência para as referidas patologias, será limitada às primeiras 12 (doze) horas ou até que ocorra a necessidade de internação.

5.1.5. Necessidade de continuidade do atendimento de urgência e emergência

Caso seja necessária, para a continuidade do atendimento de urgência e emergência, a realização de procedimento exclusivo de coberturas (cobertura hospitalar, obstétrica ou para procedimentos de alta complexidade) às quais o **Beneficiário** não tenha direito, quer por não constarem da segmentação do plano no qual se encontra cadastrado ou, quer em virtude de estar cumprindo prazo de carência ou cobertura parcial temporária; e ainda que a solicitação seja feita para que a continuidade do atendimento se dê na mesma unidade prestadora de serviços e mesmo que em tempo inferior a 12 (doze) horas, a cobertura cessará, passando a responsabilidade financeira ao **Beneficiário**, a partir de sua internação, não cabendo mais nenhum ônus à **CONTRATADA**.

5.1.6. Remoção nos casos de urgência e emergência

5.1.6.1. Beneficiário com direito a continuidade do atendimento

É assegurada ao **Beneficiário** a garantia de cobertura de remoção terrestre para unidade de atendimento da rede do plano, após realizados os atendimentos classificados como urgência e emergência, quando caracterizada, pelo médico assistente, a falta de recursos oferecidos pela unidade para continuidade de atenção ao paciente, sempre mediante solicitação expressa do médico assistente.

5.1.6.2. Beneficiário sem direito à continuidade do atendimento

É assegurado ao **Beneficiário** sem direito à continuidade do atendimento de urgência e emergência, conforme o previsto nos itens 5.1.2.; 5.1.3.; 5.1.4. e 5.1.5. acima, a garantia de cobertura de remoção terrestre para Unidade do SUS, depois de realizados os procedimentos caracterizados como urgência e emergência que determinaram a necessidade da continuidade do atendimento ou findo o prazo de 12 (doze) horas, o que ocorrer antes, sempre mediante solicitação expressa do médico assistente.

Na remoção, a **CONTRATADA** deverá disponibilizar ambulância com os recursos técnicos necessários a garantir a manutenção da vida, só cessando sua responsabilidade sobre o paciente quando efetuado o seu registro numa unidade do SUS.

Nos casos em que não possa haver remoção por risco de vida e não havendo cobertura contratual ou legal para o evento, o **Beneficiário** e o prestador do atendimento deverão negociar entre si a responsabilidade financeira da continuidade da assistência, desobrigando-se, assim, a **CONTRATADA**, de qualquer ônus daí decorrente.

Quando o **Beneficiário** ou seus responsáveis optarem, mediante assinatura de Termo de Responsabilidade, pela continuidade do atendimento em unidade que não a do SUS, a **CONTRATADA** estará desobrigada da responsabilidade médica e do ônus financeiro do atendimento e da remoção.

Nas situações em que não exista leito do SUS disponível e não existam condições médicas para a realização de remoção sem implicar em risco de vida ao paciente, a **CONTRATANTE** arcará com o ônus da assistência do **Beneficiário** até ser possível a sua remoção, ficando a **CONTRATADA** isenta de qualquer responsabilidade médica e financeira sobre o paciente.

5.1.6.3. Das limitações da remoção no atendimento de urgência e emergência

- a) Fica expressamente excluída a cobertura de qualquer remoção que não seja a terrestre, mesmo que por solicitação do médico assistente.
- b) Fica estabelecido que não haverá cobertura, por parte da **CONTRATADA**, de custos para remoção do paciente de sua residência ou local de trabalho para um hospital, nem de um hospital para a sua residência e/ou local de trabalho, ainda que por solicitação do médico assistente.

5.2. Cobertura nos casos de urgência e emergência – produtos de assistência odontológica

É obrigatória por parte da **CONTRATADA** a cobertura dos atendimentos nos casos de urgência/emergência odontológica, descritos nas **Condições do(s) Produto(s)** que regulamenta o(s) plano(s) contratado(s).

5.3. Cobertura de remoção – produtos de assistência média

A cobertura da segmentação hospitalar, nos planos em que esta segmentação esteja definida, contempla, ainda, a remoção terrestre do **Beneficiário**, na forma da legislação vigente à época do evento, que tenha cumprido o período de carência para internação hospitalar, a partir da ciência da **CONTRATADA**, e mediante solicitação expressa do médico assistente, quando ocorrer:

- a) De hospital ou pronto-atendimento vinculado ao Sistema Único de Saúde – SUS, localizado dentro da área de atuação do produto contratado, para hospital próprio ou credenciado da **CONTRATADA**, vinculado ao plano de saúde do **Beneficiário**;
- b) De hospital ou pronto-atendimento privado, não pertencente à rede assistencial da **CONTRATADA**, localizado dentro da área de atuação do produto contratado, para hospital próprio ou credenciado da **CONTRATADA**, vinculado ao plano de saúde do **Beneficiário**;
- c) De hospital ou pronto-atendimento privado, pertencente à rede assistencial da **CONTRATADA**, vinculado ao plano de saúde do **Beneficiário**, localizado dentro da área de atuação do produto contratado, para hospital próprio ou credenciado da **CONTRATADA**, apenas quando caracterizada, pelo médico assistente, a falta de recursos para continuidade de atenção ao **Beneficiário** na unidade de saúde de origem;
- d) De hospital ou pronto-atendimento, público ou privado, não pertencente à rede assistencial da **CONTRATADA**, localizado fora da área de atuação do produto contratado pelo **Beneficiário**, para hospital próprio ou credenciado da **CONTRATADA**, vinculado ao plano de saúde do **Beneficiário**, apto a realizar o devido atendimento, apenas nos casos em que o evento que originou a necessidade do serviço tenha ocorrido dentro da área de atuação do produto do **Beneficiário** e na indisponibilidade ou inexistência de prestador conforme previsto na regulamentação vigente;
- e) De hospital ou pronto-atendimento pertencente à rede assistencial da **CONTRATADA**, vinculado ao plano de saúde do **Beneficiário**, localizado dentro da área de atuação do produto contratado, para hospital próprio ou credenciado da **CONTRATADA**, vinculado ao plano de saúde do **Beneficiário**, nos casos em que houver previsão contratual para atendimento em estabelecimento de saúde específico.

5.3.1. Limitações da cobertura de remoção

A **CONTRATADA** não se responsabilizará, em nenhuma hipótese, pelas despesas de **REMOÇÃO TERRESTRE** do **Beneficiário**, ainda que por solicitação expressa do médico assistente, nas seguintes situações:

- a) De local público ou privado que não seja uma unidade hospitalar ou pronto-atendimento, ressalvadas as hipóteses de indisponibilidade e inexistência de prestadores, conforme legislação vigente ou;
- b) De hospital ou pronto-atendimento, pertencente à rede assistencial da **CONTRATADA**, vinculado ao plano de saúde do **Beneficiário**, localizado dentro da área de atuação do produto contratado, para hospital privado não pertencente à rede assistencial da **CONTRATADA**.

5.4. Cobertura de remoção – produtos de assistência odontológica

A **CONTRATADA** não se responsabilizará, em nenhuma hipótese, por despesas com qualquer tipo de **REMOÇÃO** dos beneficiários vinculados ao produto da segmentação odontológica, ainda que solicitada por odontólogo assistente, por não haver cobertura na segmentação odontológica, de acordo com o ROL da ANS.

5.5. Na hipótese de indisponibilidade de prestador integrante da rede assistencial que ofereça o serviço ou procedimento demandado, desde que previsto contratualmente, no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto, a cobertura solicitada será garantida em:

- I - Prestador não integrante da rede assistencial no mesmo município; ou
- II - Prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes a este.

5.5.1. No caso de atendimento por prestador não integrante da rede assistencial, o pagamento do serviço ou procedimento será realizado pela **CONTRATADA** ao prestador do serviço ou do procedimento, mediante acordo entre as partes.

5.5.2. Na indisponibilidade de prestador integrante ou não da rede assistencial no mesmo município ou nos municípios limítrofes a este, a operadora deverá garantir o transporte do **Beneficiário** até um prestador apto a realizar o devido atendimento, assim como seu retorno à localidade de origem, respeitados os prazos de atendimento fixados pela regulamentação vigente.

5.5.3. As hipóteses previstas pelos itens acima da garantia de atendimento no caso de indisponibilidade de prestador se aplicam ao serviço de urgência e emergência, sem necessidade de autorização prévia.

5.6. Na hipótese de inexistência de prestador, seja ele integrante ou não da rede assistencial, que ofereça o serviço ou procedimento demandado, no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto, a **CONTRATADA** deverá garantir atendimento em:

- I - Prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes a este; ou
- II - Prestador integrante ou não da rede assistencial na região de saúde à qual faz parte o município.

5.6.1. Na inexistência de prestadores nas hipóteses listadas nos incisos I e II da cláusula 5.6, a **CONTRATADA** garantirá o transporte do **Beneficiário** até um prestador apto a realizar o devido atendimento, assim como seu retorno à localidade de origem, respeitados os prazos de atendimento fixados pela regulamentação vigente.

5.6.2. No caso de impossibilidade da garantia de atendimento pela **CONTRATADA**, de acordo nas hipóteses de indisponibilidade e inexistência de prestador conforme previsto neste **CONTRATO** e na regulamentação vigente, caso o **Beneficiário** seja obrigado a pagar os custos do atendimento, a **CONTRATADA** procederá com o reembolso integral no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data da solicitação de reembolso, inclusive as despesas com transporte.

5.6.3. A possibilidade de reembolso acima aludida, somente será obrigatoriamente atendida quando a **CONTRATADA** tiver sido devida e expressamente comunicada pelo **Beneficiário** do fato gerador, e não tiver garantido o atendimento dentro dos prazos previstos na legislação e regulamentação vigente.

5.6.3.1. No momento da comunicação, o **Beneficiário** receberá um número de protocolo que deverá obrigatoriamente acompanhar e identificar os documentos exigidos para o reembolso, que são os mesmos previstos no item 7.4.1.11 deste **INSTRUMENTO**.

5.6.4. O reembolso para todos os planos com opção de acesso à livre escolha de prestadores será efetuado nos limites estabelecidos contratualmente para cada plano.

6. PADRÃO DE ACOMODAÇÃO

O padrão de acomodação varia de acordo com o plano em que o **Beneficiário** esteja devidamente cadastrado, pois a acomodação faz parte das características dos planos contratados, e fazem referência ao tipo de acomodação a que o beneficiário terá acesso em caso de internação hospitalar ou obstétrica, diferenciando-se em:

- a) Acomodação em quarto individual com banheiro;
- b) Acomodação em quarto coletivo, a partir de 2 (dois) leitos.

Os produtos da segmentação Odontológica não possuem acomodação.

6.1. Acompanhantes na internação

De acordo com o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS vigente e com o previsto na legislação, o **Beneficiário** somente terá direito à cobertura de despesas de diária(s) de 1 (um) acompanhante, no caso de:

- a) Ser menor de 18 (dezoito) anos;
- b) Ter idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos;
- c) Ser portador de necessidades especiais.

Ressalvadas as situações de:

- i) Contraindicação justificada do médico ou do cirurgião-dentista assistente, no local da internação; ou
- ii) Nos casos de internação em Unidade de Terapia Intensiva - UTI ou similar.

A indicação do acompanhante deverá respeitar as políticas administrativas do prestador hospitalar onde se der a internação.

A cobertura de despesas de diária do acompanhante sempre se dará no padrão de acomodação do plano em que o **Beneficiário** esteja cadastrado.

6.2. A segmentação assistencial obstétrica garantirá, além dos procedimentos previstos na segmentação hospitalar, a cobertura dos procedimentos relativos ao pré-natal, assistência ao parto e puerpério, observadas as seguintes exigências:

- a) Cobertura das despesas, incluindo paramentação, acomodação e alimentação, relativas ao acompanhante indicado pela mulher durante o pré-parto, parto e pós-parto imediato, entendido como o período que abrange 10 (dez) dias após o parto, salvo intercorrências, a critério médico;
- b) Cobertura assistencial ao recém-nascido(a), filho(a) natural ou adotivo(a) do **Beneficiário**, ou de seu dependente, durante os 30 (trinta) primeiros dias após o parto;
- c) Opção de inscrição assegurada ao recém-nascido(a), filho(a) natural ou adotivo(a) do **Beneficiário**, como dependente, isento do cumprimento dos períodos de carência, desde que a inscrição ocorra no prazo máximo de 30 (trinta) dias do nascimento ou adoção.

A indicação do acompanhante deverá respeitar as políticas administrativas do prestador hospitalar onde se der a internação.

A cobertura de despesas de diária do acompanhante sempre se dará no padrão de acomodação do plano em que o **Beneficiário** esteja cadastrado.

7. EXCLUSÕES DE COBERTURA

A **CONTRATADA** está **totalmente eximida** de oferecer qualquer cobertura que não esteja prevista na cláusula 5 do presente **INSTRUMENTO** ou em qualquer situação em que a segmentação, abrangência geográfica, acomodação e redes assistenciais de acordo com o plano em que forem devidamente cadastrados e que se encontram elencados nos produtos contratados, não sejam estritamente observados.

A **CONTRATADA**, da mesma forma, se exime da cobertura caso os períodos de carência para o procedimento solicitado ou cobertura parcial temporária (CPT), quando seja o caso, à que os **Beneficiários** estejam sujeitos, não tenham sido cumpridos.

Também não serão cobertos, os procedimentos solicitados em desacordo com as normas de atendimento da **CONTRATADA** e que desrespeitem as orientações dadas aos **Beneficiários**, os prazos previstos e a necessidade de autorização prévia por parte da **CONTRATADA**, bem como as situações em que o **Beneficiário** não comprove efetivamente o vínculo com a **CONTRATANTE** ou sua identidade.

Nas **Condições do(s) Produto(s)**, que individualizam cada produto contratado, que fazem parte da documentação anexa ao presente **INSTRUMENTO**, estão detalhadas todas as exclusões contratuais de cobertura dos procedimentos, bem como suas demais particularidades.

7.1. Exclusão de remoção aérea

A **CONTRATADA** não se responsabilizará, em nenhuma hipótese, por despesas com REMOÇÃO AÉREA dos **Beneficiários** do presente **CONTRATO**, ainda que solicitada pelo médico assistente.

7.2. Exclusão de internação domiciliar

Não será garantida a internação domiciliar (HOME CARE), seja em substituição à internação hospitalar ou não, e ainda que solicitada ou prescrita pelo médico assistente do **Beneficiário**.

7.3. Exclusão de cobertura nos casos psiquiátricos

Não será garantida pela **CONTRATADA** qualquer **internação psiquiátrica** que não se der em hospital psiquiátrico ou em unidade/enfermaria em hospital geral para internação psiquiátrica, exclusivamente para os produtos contratados. Também não serão cobertas pela **CONTRATADA** as internações de caráter social ou para recuperação de dependência química em clínicas de reabilitação, centros de convivência, clínicas de repouso, spas e afins.

7.4. Exclusão de cobertura de reembolso

Nos planos da **CONTRATADA** que não prevejam a modalidade de livre escolha de prestadores em seu registro junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, não estará coberto o reembolso de procedimentos, eximindo-se assim a **CONTRATADA** de qualquer ressarcimento nesse sentido.

7.4.1. Nos casos específicos em que **Beneficiário** não consiga se deslocar até um prestador pertencente à rede assistencial em situações de urgência e emergência em razão da gravidade, exclusivamente, dentro das

áreas de abrangência geográfica e atuação de cada produto, a **CONTRATADA** poderá efetuar o reembolso de despesas nos limites dos custos com que arcaria em situações de igual natureza, mediante a comprovação documental do evento por meio da apresentação dos documentos elencados nas previsões deste **CONTRATO** e apuração das circunstâncias do referido atendimento. O cálculo do reembolso será efetuado de acordo com TABELA DE REEMBOLSO, observadas a fórmula de cálculo e documentação obrigatória previstas neste **CONTRATO**, de forma que o valor a ser pago não será superior ao valor dos honorários e despesas da **CONTRATADA** pagas a um prestador da rede assistencial.

MÚLTIPLOS DE REEMBOLSO PARA ATENDIMENTOS		
TIPO DE COBERTURA PARA REEMBOLSO		MÚLTIPLOS
COBERTURAS HOSPITALARES E DIÁRIAS	Diárias e taxas hospitalares	1 x Tabela
	Serviços auxiliares de diagnose e terapias	1 x Tabela
	Honorários médicos	1 x Tabela
COBERTURAS AMBULATORIAIS E TAXAS	Consultas médicas	1 x Tabela
	Exames	1 x Tabela
	Terapias	1 x Tabela

7.4.1.1. Serão cobertos os materiais e medicamentos utilizados ou ministrados dentro do período de internação hospitalar ou atendimentos em pronto-socorro, sempre observada a segmentação do plano contratado e desde que previstos no presente **INSTRUMENTO**, medicamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, de acordo com as Diretrizes de Utilização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, vigente à época do evento, sendo reembolsados de acordo com os valores negociados com o prestador de serviços e não serão superiores aos constantes nos materiais publicados pelo Brasíndice e Simpro respectivamente, vigentes na data de sua utilização, de forma a garantir o que determina a legislação e regulamentação vigente.

7.4.1.1.1. Estão excluídos os medicamentos importados não nacionalizados, que não terão Cobertura, de acordo com o disposto no presente **INSTRUMENTO** em total consonância com a legislação e regulamentação vigente.

7.4.1.2. As despesas médicas pagas diretamente pelo **Beneficiário Titular** ou **Dependente**, com os serviços de assistência à saúde cobertos por este **INSTRUMENTO**, serão reembolsadas após conferência e aprovação da conta médica, com base na Tabela Procedimentos Médicos da **CONTRATADA**, cujo valor não será inferior ao da Tabela praticada pela **CONTRATADA** junto à rede prestadora e até o limite do valor das notas apresentadas pelo **CONTRATANTE**.

7.4.1.3. A Tabela de Procedimentos Médicos da **CONTRATADA** estará disponível para consulta dos **Beneficiários** na sua sede e no portal da **CONTRATADA**, o qual informará ainda o Cartório de Registro de Títulos e Documentos onde a tabela encontra-se registrada. Em caso de dúvidas ou esclarecimentos referentes a esta tabela, o **Beneficiário** poderá contar a Central de Atendimento da **CONTRATADA**.

7.4.1.4. Quando as despesas decorrentes dos atendimentos médicos, prestados ao **Beneficiário Titular** ou **Dependente** com serviço de assistência à saúde coberta pelo **CONTRATO**, vierem a ser faturadas diretamente pelo prestador a **CONTRATADA**, a eventual diferença entre o valor cobrado pelo prestador e a base da Tabela de Procedimentos Médicos será faturada para a **CONTRATANTE**, no mês subsequente, acompanhada da documentação comprobatória da cobrança.

7.4.1.5. Para efeito do cálculo dos valores de reembolso, a **US – UNIDADE DE SERVIÇO** tem seu valor fixado inicialmente em R\$ 1,00 (um real).

7.4.1.6. O cálculo do reembolso, em reais, será apurado por meio da seguinte fórmula:

$$REEMBOLSO = N^{\circ} \text{ de US} \times \text{Valor US} \times \text{Múltiplo do Plano} + \text{UCO (quando aplicável)}$$

Onde:

Nº de US (UNIDADE DE SERVIÇO): é o quantitativo apresentado na Tabela de Reembolso para o respectivo procedimento.

Valor da US: é o valor em reais para o cálculo do valor devido como reembolso.

Múltiplo do Plano: é o número de vezes que, de acordo com o plano contratado, aplicado sobre o *Nº de US*, indicará o valor de reembolso.

UCO (Unidade de Custo Operacional): é o valor em reais a ser incluído ao cálculo do reembolso dos exames, terapias e procedimentos.

Exemplos:

a) Consulta médica – Quantidade de US, conforme Tabela de Reembolso – 75

Valor em moeda corrente da US R\$ 1,00

Múltiplo de reembolso para Consultas Médicas do plano – 1X Tabela de Reembolso

Valor do reembolso = $75 \times 1,00 \times 1 = \text{R\$ } 75,00$

b) Eletrocardiograma Convencional (de até 12 derivações) – Quantidade de US, conforme Tabela de Reembolso – 19,03

Valor em moeda corrente da US R\$ 1,00

Múltiplo de reembolso para Consultas Médicas do plano – 1X Tabela de Reembolso

UCO em moeda corrente (Exames) - R\$7,95

Valor do reembolso = $19,03 \times 1,00 \times 1 + 7,95 = \text{R\$ } 26,98$

c) Acupuntura por sessão – Quantidade de US, conforme Tabela de Reembolso – 59,38

Valor em moeda corrente da US R\$ 1,00

Múltiplo de reembolso para Consultas Médicas do plano – 1X Tabela de Reembolso

UCO em moeda corrente (Terapias) - R\$8,48

Valor do reembolso = $59,38 \times 1,00 \times 1 + 8,48 = \text{R\$ } 67,86$

7.4.1.7. Em nenhuma hipótese o valor a ser reembolsado superará o total do valor apresentado das despesas, mesmo que o limite financeiro de reembolso para o(s) procedimento(s) em questão seja(m) superior(es) ao(s) valor(es) apresentado(s).

7.4.1.8. O reajuste do valor da US para cálculo dos limites de reembolso, poderá considerar a variação dos custos médico-hospitalares dos procedimentos cobertos por este **CONTRATO**, não estando de qualquer forma vinculado ao índice de reajuste financeiro ou técnico do **CONTRATO**, tendo como parâmetro o que dispõe a legislação e regulamentação vigentes.

7.4.1.9. Nos casos relacionados no item 7.4.1 e dentro dos limites das obrigações deste **CONTRATO**, obedecendo a área de abrangência geográfica, a área de atuação do plano contratado e os mecanismos de regulação, deverão ser observadas as seguintes regras:

7.4.1.10. As despesas médicas pagas diretamente pelo **Beneficiário Titular** ou **Dependente**, com os serviços de assistência à saúde cobertos por este **CONTRATO**, serão reembolsadas após conferência e aprovação da conta médica, com base na Tabela de Reembolso e não será inferior ao da Tabela praticada pela **CONTRATADA** junto à rede prestadora e até o limite do valor das notas apresentadas pelo **CONTRATANTE**.

7.4.1.10.1. Quando as despesas decorrentes dos atendimentos médicos, prestados ao **Beneficiário Titular** ou **Dependente** com serviço de assistência à saúde coberta pelo **CONTRATO**, vierem a ser faturadas diretamente pelo prestador a **CONTRATADA**, a eventual diferença entre o valor cobrado pelo prestador e a base da **TABELA DE REEMBOLSO** será faturada para a **CONTRATANTE**, no mês subsequente, acompanhada da documentação comprobatória da cobrança.

7.4.1.11. O **Beneficiário**, para obtenção do reembolso previsto no item anterior, deverá obedecer aos seguintes requisitos:

7.4.1.11.1. O **Beneficiário** ou seu responsável deverá comunicar a ocorrência à **CONTRATADA** em até 48 (quarenta e oito) horas após o início do atendimento para obtenção do número de protocolo do evento.

7.4.1.11.2. O Reembolso será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a partir da data de entrega pelo **Beneficiário** da documentação completa exigida para:

7.4.1.11.2.1. Consultas médicas - Os recibos em impresso próprio do prestador, ou notas fiscais originais e quitadas, devem conter as seguintes especificações:

- a) Nome completo do **Beneficiário** atendido;
- b) Local e data da realização da consulta;
- c) Valor cobrado (numérico e por extenso);
- d) Nome completo do médico (quando pessoa física) com número de CPF ou razão social da Clínica com o número do CNPJ, endereço completo e telefone;
- e) Especialidade médica, número de inscrição no Conselho Regional de Medicina – CRM e assinatura do médico;
- f) Diagnóstico: CID 10, desde que autorizado pelo **Beneficiário**.
- g) **Consulta Psiquiátrica:** Enviar junto com a documentação, Relatório Médico com o Diagnóstico e Tratamento efetuado;
- h) **Consulta Pré-Natal:** Enviar junto com a documentação, Relatório Médico informando o tempo de gestação.

7.4.1.11.2.1.1. Serão cobertas as consultas com o mesmo médico no intervalo mínimo de 30 (trinta) dias entre uma e outra, uma vez que o valor de reembolso de cada consulta, já contempla os retornos até 30 (trinta) dias.

7.4.1.11.2.1.2. Para um mesmo atendimento, não devem ser emitidos pelos médicos e apresentados para reembolso, 02 (dois) ou mais recibos.

7.4.1.11.2.2. Exames complementares e tratamentos ambulatoriais/Terapias - Os recibos em impresso próprio do prestador, ou notas fiscais originais e quitadas, devem conter as seguintes especificações:

- a)** Nome completo do **Beneficiário** atendido;
- b)** Local e data da realização de cada exame ou tratamento; (nos casos de terapias seriadas, informar a data de realização de cada sessão e constar a assinatura do paciente nas mesmas (controle de frequência);
- c)** Descrição completa de cada exame ou tratamento, informando a região corpórea (exames por imagem) com os respectivos valores individualizados, incluindo o número de sessões quando for o caso;
- d)** Nome e tipo específico, com o valor individualizado de cada exame ou tratamento, inclusive com o número de sessões; bem como todos os materiais ou medicamentos que possam porventura ter sido utilizados com suas respectivas quantidades e valores unitários;
- e)** Razão social do laboratório, clínica ou serviço utilizado, endereço completo e telefone, com o número do CNPJ e assinatura do responsável;
- f)** No caso de honorários profissionais será necessário o nome do médico ou profissional com o seu CPF ou nome da clínica e respectivo CNPJ, a especialidade do médico, número de inscrição no CRM e assinatura do médico;
- g)** Relatório com quadro clínico, diagnóstico e programação terapêutica.
- h)** Laudo do exame anátomo patológico (se realizado);
- i)** Laudos de exames de imagem e exames laboratoriais;
- j)** Nome do médico/ terapeuta, especialidade, carimbo, assinatura, número e tipo da inscrição no respectivo conselho;
- k)** Fisioterapia/Acupuntura: só serão reembolsadas se solicitadas por profissional inscrito no CRM;
- l)** Radioterapia: Enviar também as cobranças dos médicos e hospital (custo operacional), caso haja cobrança separada;
- m)** Todas as solicitações de reembolso de exames complementares e tratamentos ambulatoriais deverão ser acompanhadas obrigatoriamente das respectivas solicitações do médico assistente (pedido médico). A solicitação deverá conter especificamente:
 - m.1)** Nome completo do **Beneficiário** atendido;
 - m.2)** Hipótese diagnóstica que motivou a solicitação do exame; CID 10, desde que autorizado pelo **Beneficiário**;
 - m.3)** Data da elaboração do pedido médico;
 - m.4)** Carimbo com nome completo do médico, nº do CRM, especialidade e assinatura;
 - m.5)** Endereço e telefone para contato com o médico assistente, caso necessário.

7.4.1.11.2.2.1. A **CONTRATADA** poderá solicitar os resultados dos exames realizados para fins de reembolso, a critério da avaliação da auditoria médica, resguardado o sigilo médico.

7.4.1.11.2.2.2. Todos os exames complementares deverão vir acompanhados do respectivo pedido médico, que terá validade de 30 (trinta) dias a partir da data de emissão.

7.4.1.11.2.3. Internações ou procedimentos hospitalares - Os recibos em impresso próprio do prestador, ou notas fiscais originais e quitadas, devem conter as seguintes especificações:

- a) Nome completo do **Beneficiário** atendido;
- b) Local, data e horário do atendimento hospitalar e as datas de internação, visitas médicas em casos clínicos e alta hospitalar, se for o caso;
- c) Conta hospitalar em via original e quitada, discriminada com o valor unitário de cada item de despesa e tipo específico de procedimentos realizados;
- d) Razão social do hospital, com número do CNPJ e assinatura do responsável;
- e) Para reembolso de honorários médicos é necessário apresentar recibos ou notas fiscais referentes a cada médico com seu CPF ou nome da Clínica e seu CNPJ, a especialidade e atuação de cada médico (cirurgiões, auxiliares, anestesistas, assistência ao recém-nascido, visitas hospitalares, etc.), discriminação de cada serviço e valor correspondente, carimbo contendo número de inscrição no CRM e assinatura de cada médico e discriminação do valor de cada cirurgia (em caso de múltiplas intervenções cirúrgicas);
- f) Relatório de alta hospitalar da internação, devidamente preenchido pelo médico assistente do paciente, com as informações médicas referentes ao evento, diagnóstico, tempo de existência da doença, tratamento realizado, período de internação, quantidade de visitas realizadas e respectivas datas;
- g) Quando houver a extirpação de órgãos, tumores ou lesões, deverá ser anexado o laudo do exame anatomopatológico e cópia da transcrição cirúrgica;
- h) Laudo de exames anátomo patológicos, colangiografias intraoperatórias ou polissonografias (caso tenham sido realizadas) e descrição cirúrgica em procedimentos complexo ou divergentes do autorizado;
- i) Nota fiscal de compra de materiais especiais, órteses e próteses, informando: marca, modelo e fabricante;
- j) Relatório médico preenchido pelo médico assistente, contendo a descrição de todos os procedimentos utilizados com justificativa da urgência ou emergência. Quando houver retirada cirúrgica de órgãos ou lesões, deve ser anexada cópia do exame anatomopatológico.

7.4.1.11.2.4. Despesas com Transporte

- a) **Remoção em Ambulância:** Relatório Médico justificando a necessidade de remoção, diagnóstico do paciente, indicando a data do evento, local de saída, destino e quilometragem percorrida, especificação do tipo de ambulância (UTI ou Ambulância simples);
 - a.1) Somente serão reembolsadas as despesas acompanhadas de relatórios médicos, caracterizando a necessidade de remoção de hospital para hospital;
- b) **Taxi e apps de viagens:** Recibo original indicando as seguintes informações: - Valor do recibo em numerário e por extenso; - Origem e Destino; Placa do Veículo; Nome e Telefone do taxista; -Telefone do ponto de taxi/cooperativa; - Local e data da realização do serviço; - Assinatura do Taxista.
- c) **Transporte Coletivo** público ou privado Intermunicipal ou interestadual (ônibus, trem, barco): Recibo original emitido pela Cia. utilizada como transporte.
- d) **Veículo particular:** Será tomada como base para reembolso a menor distância entre origem e destino, considerando verba específica por quilometro rodado;

7.4.1.12. Após a análise administrativa, de direitos contratuais, de avaliação técnica e de valores descontados as eventuais divergências, o reembolso será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da entrega à **CONTRATADA** da documentação completa descrita no item anterior.

7.4.1.13. Excepcionalmente nos casos em que o **Beneficiário** (Titular e/ou dependente), não solicitar o reembolso, ficará facultado a este, o direito de pleitear o reembolso a **CONTRATADA**, dentro do limite pré-estabelecido de no máximo de 01(um) ano, referente ao prazo de prescrição constante na lei vigente, sendo

resguardado a **CONTRATADA**, nestes casos, o pagamento das despesas em até 30 (trinta) dias após a entrega e conferência da documentação (art. 206 do Código Civil).

7.4.1.14. O Reembolso será efetivado por depósito na conta bancária do **Beneficiário Titular** e informada por ele em solicitação de reembolso por escrito, não sendo permitida utilização da conta bancária de terceiros.

8. CARÊNCIAS CONTRATUAIS

8.1. Definição

Carência – Entende-se por Carência o período corrido e ininterrupto, determinado em contrato, contado a partir da data de início da vigência do **Beneficiário** no plano de assistência à saúde ao qual seja vinculado, durante o qual a **CONTRATANTE** paga as contraprestações pecuniárias, mas o **Beneficiário** sujeito ao cumprimento de carência, ainda não tem acesso a determinadas coberturas previstas no contrato.

8.2. Prazo para cadastramento dos Beneficiários com isenção do cumprimento de carências

As partes acordam que, uma vez que o **CONTRATO** tenha mais que 30 (trinta) vidas, os **Beneficiários** serão isentos do cumprimento de carências quando:

- a) Forem incluídos em até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data da vigência do presente **INSTRUMENTO** para todos os **Beneficiários** da massa inicial;
- b) Forem incluídos no período de 0 (zero) até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data de admissão do novo funcionário para os **Beneficiários** ativos e seus respectivos **Beneficiários Dependentes** incluídos juntamente com ele;
- c) Forem incluídos em até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data do evento gerador de vínculo (casamento/nascimento/adoção) para os **Beneficiários Dependentes** e no caso de o **Beneficiário Titular** já ter cumprido todos os prazos de carência.

8.3. Períodos de carência

Em conformidade com a regulamentação vigente, que permite a exigência de cumprimento de prazos de carência, o direito de atendimento dos **Beneficiários** deste **INSTRUMENTO** se encontra vinculado aos seguintes prazos de carência para os procedimentos previstos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, da ANS, de acordo com a(s) segmentação(ões) do plano ao qual estiverem registrados/cadastrados:

8.3.1. Para os produtos de ASSISTÊNCIA MÉDICA

8.3.1.1. O direito de atendimento do **Beneficiário**, de acordo com as coberturas previstas na(s) segmentação(ões) assistencial(is) do plano no qual ingressou, encontrar-se-á vinculado, a contar da data do seu efetivo ingresso no plano, aos prazos de carência estabelecidos, conforme abaixo:

I – Para as empresas com um universo de 02 a 15 Beneficiários, quando a inscrição do Beneficiário ocorrer EM ATÉ 30 dias contados: a) da data de assinatura do **CONTRATO**; b) da data de admissão na pessoa jurídica **CONTRATANTE**:

a) 24 (vinte e quatro) horas: para a cobertura de acidentes pessoais, ocorridos comprovadamente após a vigência do **CONTRATO** e complicações decorrentes do processo gestacional, sendo que as demais condições de atendimento de urgência/emergência estão detalhadas na Cláusula de Urgência/emergência, conforme a CONSU No. 13/98; - para consultas médicas e exames laboratoriais simples (exceto Imunológicos, Hormonais e PAC), Raio X simples (Radiografia não contrastada) e Eletrocardiograma;

b) 60 (sessenta) dias: para procedimentos odontológicos (somente para planos com cobertura odontológica); - para exames Cardiológicos simples (Teste Ergométrico, Holter, Ecocardiograma (exceto PAC); - para exames Oftalmológicos simples (Curva Tensional, Tonometria, Campimetria, Mapeamento de Retina (exceto PAC); - para exames Otorrinolaringológicos simples (Audiometria e Impedanciometria, Pesquisa de Potencial Evocado (BERA) (exceto PAC); - para Raio X contrastado (exceto PAC); - para Ultrassonografias (exceto endoscópicas ou PAC); - para Mamografia e Densitometria Óssea.

c) 180 (cento e oitenta) dias: para Internações Hospitalares, clínicas ou cirúrgicas (exceto as relacionadas a patologias sob CPT); - para Cirurgias Ambulatoriais (exceto as relacionadas a patologias sob CPT); - para Tomografia Computadorizada, Ressonância Magnética, Endoscopia, Colonoscopia, Medicina Nuclear, Angiografia (cerebral central e/ou periférica), procedimentos que necessitem de Hemodinâmica (Cateterismo Cardiológico), Radioterapia, Quimioterapia (exceto os relacionados a patologias sob CPT); - Consultas, Sessões e Terapias Simples, Especiais, Isoladas e Multidisciplinares, inclusive, com métodos específicos – ABA, BOBATH e outras - (como psicoterapia, fonoaudiologia, nutricionista, fisioterapia, e terapia ocupacional) - para todos os procedimentos não mencionados nos itens anteriores.

d) 300 dias: para parto a termo (somente para planos com cobertura obstétrica)

II – Para as Empresas com um universo de 16 a 29 Beneficiários, quando a inscrição do Beneficiário ocorrer EM ATÉ 30 dias contados: a) da data de assinatura do **CONTRATO**; b) da data de admissão na pessoa jurídica **CONTRATANTE**; c) da data do casamento/união estável ou do nascimento/adoção:

a) 24 (vinte e quatro) horas: para a cobertura de acidentes pessoais, ocorridos comprovadamente após a vigência do **CONTRATO** e complicações decorrentes do processo gestacional, sendo que as demais condições de atendimento de urgência/emergência estão detalhadas na Cláusula de Urgência/emergência, conforme a CONSU No. 13/98; - consultas médicas e exames laboratoriais simples (exceto Imunológicos, Hormonais e PAC), Raio X simples (Radiografia não contrastada) e Eletrocardiograma; - para exames Cardiológicos simples (Teste Ergométrico, Holter, Ecocardiograma (exceto PAC); - para exames Oftalmológicos simples (Curva Tensional, Tonometria, Campimetria, Mapeamento de Retina (exceto PAC); - para exames Otorrinolaringológicos simples (Audiometria e Impedanciometria, Pesquisa de Potencial Evocado (BERA) (exceto PAC); - para Raio X contrastado (exceto PAC); - para Ultrassonografias (exceto endoscópicas ou PAC); - para Mamografia e Densitometria Óssea.

b) 60 (sessenta) dias: para procedimentos odontológicos (somente para planos com cobertura odontológica).

c) 180 (cento e oitenta) dias: - para Internações Hospitalares, clínicas ou cirúrgicas (exceto as relacionadas a patologias sob CPT); - para Cirurgias Ambulatoriais (exceto as relacionadas a patologias sob CPT); - para Tomografia Computadorizada, Ressonância Magnética, Endoscopia, Colonoscopia, Medicina Nuclear, Angiografia (cerebral central e/ou periférica), procedimentos que necessitem de Hemodinâmica (Cateterismo Cardiológico), Radioterapia, Quimioterapia (exceto os relacionados a patologias sob CPT); - Consultas, Sessões e Terapias Simples, Especiais, Isoladas e Multidisciplinares, inclusive, com métodos específicos – ABA, BOBATH e outras - (como psicoterapia, fonoaudiologia, nutricionista, fisioterapia, e terapia ocupacional) - para todos os procedimentos não mencionados nos itens anteriores.

d) 300 dias: para parto a termo (somente para planos com cobertura obstétrica).

III – Para as Empresas com um universo de 02 a 15 OU 16 a 29 OU acima de 30 Beneficiários, quando a inscrição do Beneficiário ocorrer APÓS 30 dias contados: a) da data de assinatura do CONTRATO; b) da data de admissão na pessoa jurídica CONTRATANTE; c) da data do casamento/união estável ou do nascimento/adoção:

a) 24 (vinte e quatro) horas: para a cobertura de acidentes pessoais, ocorridos comprovadamente após a vigência do **CONTRATO** e complicações decorrentes do processo gestacional, sendo que as demais condições de atendimento de urgência/emergência estão detalhadas na Cláusula de Urgência/emergência, conforme a CONSU No. 13/98.

b) 30 (trinta) dias: consultas médicas e exames laboratoriais simples (exceto Imunológicos, Hormonais e PAC), Raio X simples (Radiografia não contrastada) e Eletrocardiograma;

c) 60 (sessenta) dias: para procedimentos odontológicos (somente para planos com cobertura odontológica). **d) 90 (noventa) dias:** - para exames Cardiológicos simples (Teste Ergométrico, Holter, Ecocardiograma (exceto PAC); - para exames Oftalmológicos simples (Curva Tensional, Tonometria, Campimetria, Mapeamento de Retina (exceto PAC); - para exames Otorrinolaringológicos simples (Audiometria e Impedanciometria, Pesquisa de Potencial Evocado (BERA) (exceto PAC); - para Raio X contrastado (exceto PAC); - para Ultrassonografias (exceto endoscópicas ou PAC); - para Mamografia e Densitometria Óssea.

d) 180 (cento e oitenta) dias: para Internações Hospitalares, clínicas ou cirúrgicas (exceto as relacionadas a patologias sob CPT); - para Cirurgias Ambulatoriais (exceto as relacionadas a patologias sob CPT); - para Tomografia Computadorizada, Ressonância Magnética, Endoscopia, Colonoscopia, Medicina Nuclear, Angiografia (cerebral central e/ou periférica), procedimentos que necessitem de Hemodinâmica (Cateterismo Cardiológico), Radioterapia, Quimioterapia (exceto os relacionados a patologias sob CPT); - Consultas, Sessões e Terapias Simples, Especiais, Isoladas e Multidisciplinares, inclusive, com métodos específicos – ABA, BOBATH e outras - (como psicoterapia, fonoaudiologia, nutricionista, fisioterapia, e terapia ocupacional) - para todos os procedimentos não mencionados nos itens anteriores.

e) 300 dias: para parto a termo (somente para planos com cobertura obstétrica)

IV – Para as Empresas com um universo acima de 30 Beneficiários, quando a inscrição do Beneficiário ocorrer EM ATÉ 30 dias contados: a) da data de assinatura do CONTRATO; b) da data de admissão na pessoa jurídica CONTRATANTE; c) da data do casamento/união estável ou do nascimento/adoção:

Não haverá cumprimento de prazos de carência nem cumprimento de Cobertura Parcial Temporária – CPT.

8.3.2. - Havendo a contratação de mais de um plano de assistência médico-hospitalar, poderá a **CONTRATADA**, por mera liberalidade, considerar o total de **Beneficiários** inscritos nestes planos para a contagem de participantes estipulada no subitem 8.3.1.1. desta cláusula. No entanto, em hipótese alguma, os **Beneficiários** inscritos em planos exclusivamente odontológicos serão considerados nessa contagem.

8.3.3. A descrição, diferenciação e/ou quaisquer dúvidas conceituais das carências acima, tais como exames simples, complexos e/ou de alto custo, constarão na Tabela Referência de Procedimentos e Coparticipação que estará disponível para consulta no site da **CONTRATADA**.

8.4. Depois de inscrito em um dos produtos, caso haja interesse do **Beneficiário** em migrar para outro produto dentre os contratados pelo **CONTRATANTE**, que possua as mesmas coberturas do produto anterior, mas que garanta o acesso a profissionais, entidades ou prestadores de serviços de saúde não previstos no produto anterior ou a melhor padrão de acomodação, ficará sujeito ao cumprimento do prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias para todo e qualquer procedimento em relação a esses profissionais, entidades

ou prestadores de serviços de assistência à saúde ou ao melhor padrão de acomodação acrescidos, com exceção dos casos previstos na legislação vigente. Caso opte por migrar para outro produto que possua coberturas diferentes do produto anterior, estará sujeito ao cumprimento dos períodos normais de carência previstos para os procedimentos relativos às novas coberturas.

8.5. Quando o **Beneficiário Titular** se vincular a um plano com segmentação obstétrica, será assegurada ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do consumidor, como dependente, com aproveitamento do período de carência já cumprida pelo **Beneficiário Titular**, desde que a inscrição ocorra no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados do nascimento ou da adoção.

8.6. Entre planos equivalentes ou não equivalentes da **CONTRATADA**, o **Beneficiário** poderá optar pela migração em periodicidade não inferior à anual e em data a ser estabelecida de comum acordo entre a **CONTRATADA** e **CONTRATANTE**.

8.6.1. Na transferência entre planos, o **Beneficiário** deverá permanecer no novo plano pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua efetiva transferência para o novo plano, exceto em caso de desligamento do **Beneficiário** da **CONTRATANTE**.

8.6.2. Se na solicitação de transferência do plano, o **Beneficiário** estiver cumprindo carências, estas serão mantidas até o seu término.

8.6.3. Na transferência de um plano de menor custo para outro de maior custo, o **Beneficiário** da **CONTRATANTE** somente terá direito às características do novo plano, especificamente: rede credenciada e padrão de acomodação, após 180 (cento e oitenta) dias da data da transferência. A partir da data de transferência deverá ser pago o valor correspondente ao plano de maior custo.

8.6.3.1. Na transferência de um plano sem livre escolha de prestadores para um plano com livre escolha de prestadores, conforme as regras previstas no Instrumento de Produtos, o **Beneficiário** da **CONTRATANTE** somente terá direito ao reembolso de todas as despesas comprovadamente pagas após 180 (cento e oitenta) dias da data da transferência. A partir da data de transferência deverá ser pago o valor correspondente ao plano com livre escolha de prestadores.

8.6.4. Nos casos em que o **Beneficiário Titular** for transferido de plano, todos os seus Dependentes serão automaticamente transferidos para este novo plano.

8.6.5. Caso o plano contratado contemple elegibilidade por cargos ou salários, deverão ser respeitadas as regras específicas para transferência de planos, conforme estabelecido entre as partes.

9. DOENÇAS E LESÕES PREEXISTENTES E COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA

9.1. Definições

a) DLP – **Doença ou Lesão Preexistente** é a Doença ou lesão que o **Beneficiário** ou seu representante legal saiba ser portador ou sofredor, no momento da contratação ou adesão ao plano privado de assistência à saúde;

b) DPS - **Declaração Pessoal de Saúde** é o formulário disponibilizado pela **CONTRATADA**, em que o beneficiário titular é obrigado a informar à operadora, quando expressamente solicitado, as doenças ou lesões preexistentes que saiba ser portador ou sofredor, bem como dos seus dependentes, no momento

da(s) sua(s) inclusão(ões) no plano de assistência à saúde. A omissão da informação é considerada fraude e poderá acarretar a exclusão do **Beneficiário** do plano por perda da sua qualidade de **Beneficiário**, que se dará após a publicação de encerramento do processo administrativo pela ANS;

c) CPT – Cobertura Parcial Temporária é a Cobertura assistencial que admite, por um período ininterrupto de até 24 meses, contados a partir da data de inclusão do **Beneficiário** no plano de assistência à saúde, a suspensão da cobertura de procedimentos de alta complexidade (PAC), leitos de alta tecnologia e procedimentos cirúrgicos, relacionados exclusivamente às doenças ou lesões preexistentes (DLP) declaradas pelo **Beneficiário** ou seu representante legal por ocasião da sua inclusão no plano de assistência à saúde.

9.1.1. Não haverá Cobertura Parcial Temporária para os produtos odontológicos e quando o número de **Beneficiários** for igual ou maior do que 30 (trinta), desde que atendidos, neste último caso, os prazos previstos nas hipóteses do item 8.2 acima.

9.2. Aplicabilidade ao presente INSTRUMENTO

De acordo com o previsto na regulamentação vigente, nos Contratos Coletivos Empresariais, consoantes com o teor e objeto do presente **INSTRUMENTO**, nos casos de inclusões fora dos prazos de isenção de carências pactuados no item 8.2. acima, a **CONTRADADA** exigirá o preenchimento da DPS, exceto para beneficiários que se vinculem a produtos Odontológicos, e uma vez que esta resulte positiva no sentido de comprovar a existência de DLP ensejará a aplicação da CPT para estes **Beneficiários**.

O **Beneficiário** tem o direito de preencher a Declaração de Saúde mediante entrevista qualificada orientada por um médico pertencente a rede de prestadores próprios ou credenciados pela contratada, sem qualquer ônus para o **Beneficiário**.

a) Caso o **Beneficiário** opte por ser orientado por médico não pertencente à lista de profissionais da rede assistencial da contratada, poderá fazê-lo, desde que assuma o ônus financeiro dessa entrevista.

b) O objetivo da entrevista qualificada é orientar o **Beneficiário** para o correto preenchimento da Declaração de Saúde, onde são declaradas as doenças ou lesões que o **Beneficiário** saiba ser portador ou sofredor, no momento da adesão ao presente contrato, além de esclarecer questões relativas aos direitos de cobertura e consequências da omissão de informações.

A **CONTRADADA** poderá oferecer CPT para doença(s) ou lesão(ões) que possa(m) gerar necessidade de eventos cirúrgicos, de uso de leitos de alta tecnologia e de procedimentos de alta complexidade, constatadas por perícia ou por entrevista qualificada ou por meio de declaração expressa do **Beneficiário**, conforme disposto na regulamentação vigente da ANS.

Se for identificado indício de fraude, referente à omissão de conhecimento de Doenças e Lesões Preexistentes por ocasião da contratação ou adesão ao plano, a **CONTRADADA** comunicará imediatamente ao **Beneficiário** e poderá oferecer a opção de CPT pelos meses restantes, a partir da data de recebimento do Termo de Comunicação, até completar o período máximo de 24 (vinte e quatro) meses da adesão ao presente **CONTRATO**; ou solicitar abertura de processo administrativo junto à ANS, quando da identificação do indício de fraude, ou após recusa do **Beneficiário** à CPT, nos termos da regulamentação vigente da ANS.

Após tramitação e julgamento do processo administrativo junto ANS, uma vez comprovada a omissão de informação pelo **Beneficiário**, a **CONTRADADA** poderá RESCINDIR o **CONTRATO** do **Beneficiário** por FRAUDE e responsabilizá-lo pelos procedimentos referentes a doença ou lesão não declarada.

Nos casos em que houver acordo de CPT ou Agravo, a **CONTRATADA** não poderá solicitar abertura de processo administrativo com relação à respectiva doença que ensejou o oferecimento da CPT ou Agravo.

Não será permitida a negativa de cobertura assistencial, assim como a suspensão ou rescisão unilateral de contrato, até a publicação pela ANS do encerramento do processo administrativo.

É vedada a alegação de omissão de DLP quando realizado qualquer tipo de exame ou perícia no **Beneficiário** pela **CONTRATADA**, com vistas à sua admissão no plano de assistência à saúde.

Findo o prazo de até 24 (vinte e quatro) meses da adesão ao presente **CONTRATO**, a cobertura assistencial passará a ser integral, conforme a segmentação contratada.

Os procedimentos de alta complexidade se encontram especificados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, disponível no seu site.

A **CONTRATADA** se reserva o direito de não oferecer o Agravo como opção à CPT, conforme lhe faculta a regulamentação vigente da ANS.

10. MECANISMOS DE REGULAÇÃO / REGRAS DE UTILIZAÇÃO

10.1. Habilitação para o atendimento

10.1.1. A **CONTRATADA** prestará os serviços assistenciais em conformidade com as áreas de abrangência e de atuação dos planos contratados, por meio dos prestadores próprios e/ou credenciados, constantes no Manual de Orientação do Beneficiário, a ser disponibilizado para a **CONTRATANTE** ou disponível no site da **CONTRATADA**.

10.1.2 Documentos exigidos

Ao se habilitar para qualquer tipo de atendimento, o **Beneficiário** deverá apresentar:

- a) Cartão de Identificação do Beneficiário fornecido pela **CONTRATADA**, ou disponível no seu site ou no seu aplicativo;
- b) Carteira de identidade (RG) com foto do beneficiário-paciente, no caso de menor, certidão de Nascimento e RG do acompanhante/responsável.

10.1.2.1. Casos de Atendimento que demandem autorização prévia da **CONTRATADA**

Além dos documentos acima elencados nos itens **a** e **b**, o **Beneficiário** deverá apresentar a Guia de solicitação médica ou odontológica, devidamente preenchida com o CRM do médico ou CRO do odontólogo, conforme o caso, e autorizada pela **CONTRATADA**.

10.1.3. A **CONTRATADA** se utiliza, obrigatoriamente, de processos de identificação biométrica como forma de reconhecimento para acesso aos atendimentos por parte dos **Beneficiários**. O cadastramento inicial da identificação biométrica será realizado por ocasião do primeiro atendimento do **Beneficiário** junto à rede assistencial da **CONTRATADA**, sendo obrigatória a apresentação nessa oportunidade do RG do **Beneficiário**.

10.1.3.1. Eventual liberalidade por parte da **CONTRATADA** em dispensar o **Beneficiário** da obrigação de reconhecimento por meio do processo de identificação biométrica, não lhe garante o direito de pleitear a isenção definitiva de tal obrigação que, a qualquer tempo, poderá ser novamente exigida pela **CONTRATADA**.

10.1.3.2. Caso o **Beneficiário** apresente dificuldade de se identificar por meio do processo biométrico, deverá, obrigatoriamente, comparecer ao Setor de Digitais da **CONTRATADA** para proceder com o cadastramento de suas digitais, nos termos previstos nos contratos que regulam os planos da **CONTRATADA**.

10.1.3.2.1. Se verificada pela **CONTRATADA** a impossibilidade de reconhecimento das digitais do **Beneficiário**, a **CONTRATADA** orientará, a seu critério, como será procedida a identificação do **Beneficiário** e os procedimentos que deverão ser adotados.

10.2. Atendimento eletivo

O atendimento eletivo reger-se-á pelas seguintes condições:

CONSULTAS ELETIVAS

10.2.1. Todo atendimento referente a consultas eletivas deverá ser realizado por meio dos médicos ou odontólogos e entidades indicadas no Manual de Orientação do Beneficiário ou no Portal da **CONTRATADA**, mediante marcação prévia.

EXAMES COMPLEMENTARES ELETIVOS

10.2.2. Os exames complementares dar-se-ão, **exclusivamente**, nas unidades mencionadas no Manual de Orientação do Beneficiário ou no Portal da **CONTRATADA** para as especialidades previstas.

10.2.2.1. O uso dos serviços em atendimento eletivo, para serviços de apoio diagnóstico, depende da Guia de Solicitação/Autorização da **CONTRATADA**. Alguns exames solicitados pelos médicos da **CONTRATADA** poderão já ter previa autorização.

10.2.2.2. Os exames laboratoriais, exceto os hormonais, e radiológicos de natureza simples não necessitam de autorização prévia.

10.2.2.3. Procedimentos e Exames complementares que dependem de autorização prévia:

- a)** Ultrassonografia, mamografia, anatomopatológico, cardiológico, hormonais, cariótipos;
- b)** Das especialidades médica de oftalmologia, otorrinolaringologia, dermatologia, urologia, fisioterapia, medicina nuclear, radiologia intervencionista (inclusive angiologia) e neurorradiologia;
- c)** Tomografia computadorizada, ressonância magnética, densitometria óssea, mielografias;
- d)** Exames por videoscopia;
- e)** Endoscopias diagnósticas e terapêuticas;
- f)** Hemodinâmica, litotripsia, escleroterapia de varizes;
- g)** Das especialidades odontológicas de Radiologia, Dentística, Periodontia e Endodontia;
- h)** Procedimentos de alta complexidade (PAC);
- i)** Demais exames especializados e cirurgias ambulatoriais, existentes ou que vierem a ser incluídos no ROL de procedimentos da ANS.

10.2.2.4. Quando da solicitação de procedimentos por profissionais da rede própria, poderá ser dispensada, a critério da **CONTRATADA**, a necessidade de autorização prévia dos Exames e Procedimentos Especializados.

PROCEDIMENTOS CIRURGICOS ELETIVOS

10.2.3. Todas as solicitações de procedimentos cirúrgicos eletivos dependem de autorização prévia. A solicitação deverá ser feita na central de atendimento ou nos postos de autorização, nos seguintes horários: de segunda-feira a quinta-feira, das 07h às 17h30 e, às sextas-feiras, das 07h às 16h30, por meio da apresentação da guia de solicitação (TISS) e exames/relatórios médicos comprobatórios à solicitação.

10.2.3.1. A internação será efetuada nas dependências dos hospitais indicados pela **CONTRATADA**, constantes da sua Rede, de acordo com o plano do **Beneficiário** e seu padrão de acomodação.

10.3. Autorização prévia

10.3.1. Os procedimentos que dependem de autorização prévia deverão ser solicitados pelo **Beneficiário** nas centrais de atendimento ou postos de autorização da **CONTRATADA**, nos horários estabelecidos. Nas localidades onde houver obrigação do atendimento presencial pela **CONTRATADA**, a autorização eletiva poderá ser solicitada pelo site da **CONTRATADA** ou pelo prestador executante. Em caso de dúvidas, o **Beneficiário** deverá entrar em contato com o SAC da **CONTRATADA**.

10.3.2. Ao **Beneficiário** será garantido o atendimento pelo profissional avaliador no prazo máximo de um dia útil a partir do momento da solicitação, para a definição dos casos de aplicação das regras de regulação, ou em prazo inferior quando caracterizada a urgência.

10.3.3. Nos casos em que dependam de autorização prévia, a **CONTRATADA** poderá exigir que o **Beneficiário** seja avaliado por médico ou odontólogo auditor ou, ainda, que realize exames complementares, apresente relatórios do seu médico ou odontólogo assistente, resultados de exames porventura realizados ou outros documentos necessários à avaliação da solicitação médica ou odontológica, ficando o **Beneficiário** ciente de que, havendo recusa à tal avaliação ou à apresentação da documentação solicitada, a solicitação de autorização ficará prejudicada, sem prejuízo de nova apresentação do pedido e observados os mecanismos de regulação previstos no **CONTRATO**.

10.3.4. O fato de o profissional solicitante não fazer parte da rede assistencial da **CONTRATADA** não constitui, por si só, motivo de negativa de autorização de procedimento por parte desta.

10.3.5. A impossibilidade de negativa de autorização em virtude de o profissional solicitante não pertencer à rede assistencial da **CONTRATADA**, não pressupõe o direito do **Beneficiário** à realização do procedimento com o profissional não credenciado às expensas da **CONTRATADA** e nem o exime da obrigação de submeter-se às regras de Auditoria e demais condições previstas no presente **INSTRUMENTO**.

10.3.6. Ao receber a solicitação de profissional não pertencente à sua rede assistencial, a **CONTRATADA**, por meio de sua Auditoria, analisará se o procedimento é devido, de acordo com as condições contratuais e legais de cobertura. Se o procedimento for de cobertura obrigatória, a **CONTRATADA** autorizará o procedimento para um profissional pertencente à sua rede assistencial, devidamente habilitado para a sua

realização, cabendo ao **Beneficiário** procurar o referido profissional e agendar diretamente com ele o procedimento.

10.3.7. Dependendo da natureza do procedimento, o profissional disponibilizado pela **CONTRATADA** poderá solicitar avaliação ou consulta prévia do **Beneficiário**, assim como exames complementares ou a sua apresentação, caso já realizados em prazo não superior a 30 dias.

10.3.8. A **ASSISTÊNCIA INTEGRAL**, incluindo, mas não se limitando a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo de transtornos globais do desenvolvimento, compreendendo ainda métodos e técnicas de transtorno do espectro autista, será garantida ao **Beneficiário exclusivamente** por meio de profissional habilitado pertencente à rede assistencial da **CONTRATADA** ofertado para a realização do procedimento. **Caso o Beneficiário recusar o profissional disponibilizado pela CONTRATADA e optar por realizar o procedimento por meio de profissional não pertencente à rede da CONTRATADA, correrão por conta e risco do BENEFICIÁRIO todas as despesas inerentes ao procedimento, tais como honorários do médico ou odontólogo assistente e de sua equipe (caso pertinente ao caso), materiais, equipamentos, despesas e taxas hospitalares (caso pertinente ao caso) e outros custos inerentes ao procedimento, ainda que seja realizado em prestador vinculado à CONTRATADA.**

10.3.9. Os prestadores hospitalares integrantes da rede de atendimento da **CONTRATADA** não estão obrigados a autorizar profissionais não pertencentes aos seus respectivos corpos clínicos, com o devido embasamento ético-legal, a realizarem procedimentos clínicos ou cirúrgicos em suas dependências.

10.3.10. Os procedimentos referente à tratamento terapêuticos, as sessões de Terapias Simples, Especiais, Isoladas e Multidisciplinares, inclusive, com métodos específicos – ABA, BOBATH e outras - (como psicoterapia, fonoaudiologia, nutricionista, fisioterapia, e terapia ocupacional), quando solicitados por médicos à **CONTRATADA**, serão submetidas a autorização prévia, e uma vez autorizadas serão garantidas mediante Guia de Autorização da **CONTRATADA** para realização por um profissional pertencente a rede assistencial do respectivo plano de saúde, devidamente habilitado para realização, cabendo ao **Beneficiário** identificar o referido profissional em sua rede e agendar diretamente com o profissional o procedimento.

10.3.10.1. As sessões de terapias, que dependem de autorização prévia, serão garantidas em quantidade e pela **CONTRATADA**, observadas as regras de carência do **CONTRATO**, terão suas sessões liberadas de forma gradual mediante guia de autorização de acordo com o comparecimento no prestador, garantida a realização em número e regras previstos no Rol de Procedimento da ANS, suas Diretrizes de utilização e a regulamentação vigente.

10.3.11. Todos os planos contratados por meio deste **CONTRATO** estão sujeitos ao gerenciamento de ações de saúde mediante a aplicação da regra de direcionamento à profissional e prestador exclusivamente da rede própria ou credenciada específica do plano, mesmo que existam outros credenciados nas especialidades indicadas. As condições médicas indicadas a seguir, a título de exemplo, submetem-se ao direcionamento realizado pela **CONTRATADA**:

- a) cirurgias ortopédicas;
- b) cirurgias cardiovasculares;
- c) cirurgias gástricas;
- d) neurocirurgias;
- e) implante de marcapasso ou desfibrilador cardíaco;
- f) embolização vascular cerebral;

- g) tratamento cirúrgico de obesidade mórbida e seus tratamentos acessórios e/ou subsequentes;
- h) cirurgias, consultas e exames na especialidade oftalmologia;
- i) oncologia;
- j) terapia renal substitutiva;
- k) procedimentos eletivos na especialidade de bucomaxilofacial;
- l) acompanhamento de Gestação de Risco;
- m) otorrinolaringologia (procedimentos eletivos);
- n) internação de urgência e emergência;
- o) transplantes;
- p) atendimentos com psicólogos, psicoterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas.

10.4. Atendimento de Urgência e Emergência

10.4.1. Observadas as segmentações assistências previstas nos produtos contratados conforme as **Condições do(s) Produto(s)**, ao necessitar de atendimento de consultas médicas de urgência ou emergência o **Beneficiário** deverá:

- a) Utilizar os serviços por meio dos Prontos Socorros indicados para tal no Manual de Orientação do Beneficiário ou no Portal da **CONTRATADA**, observando-se as situações descritas na cláusula de Urgência/Emergência;
- b) Após o atendimento ambulatorial, caso seja verificada a necessidade de internação, esta será garantida independentemente de autorização prévia, em conformidade com a CONSU 08/98, art. 2º, inciso V, devendo o prestador, no entanto, solicitar a autorização da internação, de imediato, à Central de Atendimento da operadora, quando da indicação médica;
- c) As autorizações para internações nos casos de urgência e emergência estarão sujeitas ao cumprimento dos prazos de carência e Cobertura Parcial Temporária, nos termos da CONSU nº 13/98, conforme previsto na cláusula 5.1 acima.

10.4.2. Produtos Odontológicos

Ao necessitar de atendimento de urgência/emergência o **Beneficiário** deverá utilizar os serviços por meio das clínicas odontológicas ou serviços odontológicos nos pronto-atendimentos indicados para tal no Manual de Orientação do Beneficiário ou no Portal da **CONTRATADA**, observando-se as situações descritas na cláusula de Urgência/Emergência.

10.4.3. As solicitações de internações de urgência e emergência serão exclusivamente direcionadas para hospitais da Rede Própria da **CONTRATADA**.

10.4.4. Quando não for possível o acesso à Rede da **CONTRATADA** para atendimento de Urgência/Emergência, o **Beneficiário** deverá proceder em conformidade com as instruções da cláusula URGÊNCIA e EMERGÊNCIA.

10.5. Rede Assistencial da CONTRATADA

A rede de prestadores da **CONTRATADA** estará disponível e poderá ser consultada por meio do site da **CONTRATADA**.

10.5.1. Quando houver descredenciamento por substituição de entidade hospitalar, a **CONTRATADA** seguirá as regras, inclusive de comunicação, editadas pela Agência Nacional de Saúde - ANS, observando ainda os critérios definidos na Lei nº 9.656/98.

10.5.2. A **CONTRATADA** poderá também, para fins de redimensionamento de sua rede assistencial, nos termos da Lei nº 9.656/98, mediante autorização da Agência Nacional da Saúde, proceder à redução da quantidade de serviços vinculados a sua rede assistencial, divulgada no Portal da Operadora.

10.5.3. Na hipótese de a substituição do estabelecimento hospitalar ocorrer por vontade da **CONTRATADA** durante período de internação do consumidor, o estabelecimento obriga-se a manter a internação e a **CONTRATADA**, a pagar as despesas até a alta hospitalar, a critério médico, na forma deste **INSTRUMENTO**.

10.5.3.1. Excetuam-se do previsto no artigo anterior os casos de substituição do estabelecimento hospitalar por infração às normas sanitárias em vigor, durante o período de internação, quando a **CONTRATADA** arcará com a responsabilidade pela transferência imediata para outro estabelecimento equivalente, garantindo a continuidade da assistência, sem ônus adicional para o consumidor.

10.5.4. Ocorrendo os descredenciamentos, os **Beneficiário** terão o direito de prosseguir o seu tratamento em qualquer outro estabelecimento hospitalar vinculado a sua rede assistencial, divulgada no Portal da Operadora, sem que a **CONTRATADA** tenha a obrigação de efetuar qualquer indenização em razão da substituição ocorrida.

10.5.5. A **CONTRATANTE** ficará responsável pela comunicação de forma individualizada ao **Beneficiário Titular** acerca dos redimensionamentos de rede hospitalar por redução, das substituições de entidades hospitalares e das exclusões de serviços de urgência e emergência ocorridos no município de residência do **Beneficiário**, devendo apresentar o comprovante de ciência quando solicitado pela **CONTRATADA**.

10.6. JUNTA MÉDICA/ODONTOLÓGICA

Nas situações de divergência técnico-assistencial sobre procedimento médico/odontológico e/ou terapêuticos realizados por profissionais da área da saúde, respeitadas as prerrogativas dos respectivos conselhos profissionais, a respeito de autorização prévia, a definição do impasse será garantida pela **CONTRATADA** por meio de junta médica/odontológica constituída pelo profissional solicitante ou nomeado pelo usuário, por médico/odontólogo nomeado pela operadora e por um terceiro, remunerado e sugerido pela **CONTRATADA**, ratificado de comum acordo pelos dois profissionais acima nomeados.

10.6.1. A Junta Médica/Odontológica será composta, processada e concluída de acordo com o estabelecido na regulamentação vigente da ANS, sujeitando-se o **Beneficiário** e os profissionais que a compõem ao fiel cumprimento das determinações ali previstas.

10.6.2. O médico/odontólogo assistente deverá escolher um dentre quatro profissionais indicados pela **CONTRATADA** para compor a JUNTA na condição de terceiro médico ou médico desempataador; a recusa, a falta de manifestação do médico/odontólogo assistente no prazo conferido no ato de convocação da Junta ou a sua manifestação fora desse prazo, importará na eleição, pela **CONTRATADA**, do terceiro médico, dentre os quatro indicados.

10.6.3. O **Beneficiário** ou o médico assistente deverão apresentar os documentos e exames que fundamentaram a solicitação do procedimento.

10.6.4. A presença do **Beneficiário** quando da realização da Junta Médica/Odontológica poderá ser dispensada, salvo quando for necessária à sua avaliação física pelos profissionais participantes, ocasião em que, a sua ausência injustificada, desobrigará a **CONTRATADA** a cobrir o procedimento solicitado.

10.6.5. O terceiro médico ou desempatador poderá solicitar fundamentadamente que o beneficiário realize exames complementares, desde que previstos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, da ANS, os quais serão cobertos pela **CONTRATADA** de acordo com as segmentações assistenciais do produto ao qual o **Beneficiário** está registrado. Nesse caso, o prazo de garantia de cobertura do procedimento inicialmente solicitado será suspenso por 03 (três) dias úteis. Caso o **Beneficiário** não realize os exames complementares solicitados pelo desempatador, prevalecerá a opinião do médico da **CONTRATADA**, ficando esta desobrigada a custear o procedimento.

10.6.6. A Junta Médica/Odontológica será concluída com a elaboração de parecer técnico de médico desempatador, o qual será acatado para fins de cobertura e que deverá ser devidamente fundamentado e cientificado ao **Beneficiário** e seu médico assistente no prazo legal.

10.6.7. A Junta Médica/Odontológica não será, obrigatoriamente, presencial, podendo, inclusive, qualquer um dos seus integrantes participar por videoconferência, telemedicina ou qualquer outro recurso que viabilize a análise da divergência técnico-assistencial de natureza médica/odontológica do procedimento solicitado.

10.6.8. Caso a Junta Médica/Odontológica seja desfavorável à solicitação do médico/odontólogo assistente, a **CONTRATADA** se desobriga de cobrir os custos do procedimento solicitado, passando este a ser de inteira e exclusiva responsabilidade do **Beneficiário**.

10.6.9. Caso a Junta Médica/Odontológica decida por um procedimento diferente do solicitado pelo médico/odontólogo, de cobertura obrigatória pela **CONTRATADA**, este será garantido, se for da vontade do **Beneficiário**, de acordo com os parâmetros técnicos definidos pelo executante pertencente à rede de atendimento da **CONTRATADA** e devidamente habilitado para execução do procedimento. Não sendo da vontade do **Beneficiário**, fica a **CONTRATADA** isenta de qualquer responsabilidade financeira sobre o procedimento solicitado.

10.7. SOLICITAÇÃO DE ÓRTESES E PRÓTESES

10.7.1. A solicitação de órteses e próteses ligadas aos atos cirúrgicos listados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, da ANS, deverão obedecer às disposições abaixo, conforme determinação da regulamentação vigente da ANS.

10.7.2. Cabe ao médico ou odontólogo assistente determinar as características (tipo, matéria-prima e dimensões) das órteses, das próteses e dos materiais especiais necessários ao procedimento.

10.7.3. O médico ou odontólogo assistente deve justificar clinicamente a sua indicação e oferecer, pelo menos, 3 (três) marcas de produtos de fabricantes diferentes, quando disponíveis, dentre aquelas regularizadas junto à ANVISA, que atendam às características especificadas.

10.7.4. Caso o médico ou odontólogo assistente não indique, pelo menos, as 3 (três) marcas nos termos do item anterior ou caso a **CONTRATADA** discorde das marcas indicadas, será instaurada Junta Médica/Odontológica.

10.8. ORIENTAÇÕES GERAIS DE ATENDIMENTO

10.8.1. O **Beneficiário** fica ciente de que, para fins de cumprimento dos prazos legais de garantia previstos na legislação, será considerado o acesso a qualquer prestador da rede assistencial, habilitado para o atendimento no município onde demandar e, não necessariamente, a um prestador específico de sua livre escolha.

10.8.2. As partes contratantes pactuam que, objetivando propiciar o melhor atendimento possível ao **Beneficiário**, bem como a melhor adequação dos custos assistenciais, fica facultado à **CONTRATADA** o traslado do **Beneficiário** para tratamentos e procedimentos em outras localidades, pertencentes à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto, nas quais disponibilize estrutura própria ou credenciada apta a lhe oferecer condições terapêuticas avançadas e seguras, cabendo, ainda, à **CONTRATADA** suportar integralmente as despesas advindas do transporte do paciente.

10.8.2.1. Nos casos de pacientes menores de 18 (dezoito) anos e a partir de 60 (sessenta) anos, a **CONTRATADA** responsabilizar-se-á, também, pelas despesas de transporte do acompanhante.

10.8.3. Nas internações hospitalares, os **Beneficiários** permanecerão hospitalizados enquanto houver indicação médica para tanto.

10.8.4. Caso o **Beneficiário** continue hospitalizado após a alta médica, passarão a correr, inteiramente por sua conta, a partir de então, todas as despesas decorrentes da internação.

10.8.5. Os serviços diagnósticos, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais podem ser solicitados pelo médico ou odontólogo assistente, não havendo restrição aos não pertencentes à rede própria ou contratualizada da operadora referenciados/cooperados/credenciados.

10.8.6. Para as solicitações de negativas de cobertura por escrito, conforme previsto na regulamentação vigente da ANS, os **Beneficiários** deverão se dirigir às unidades de atendimento administrativo da **CONTRATADA** ou entrar em contato com o seu SAC. Não compete aos prestadores da **CONTRATADA** emitirem negativas de atendimento por escrito. Aquelas que porventura o venham a ser, não serão reconhecidas pela **CONTRATADA**.

10.9. Mecanismos de regulação financeira

10.9.1. Definições

a) COPARTICIPAÇÃO é a importância, além da contraprestação mensal, a ser paga pelo **CONTRATANTE** diretamente à **CONTRATADA**, para o custeio de parte da despesa de determinado procedimento a ser realizado pelos **Beneficiários Titulares** ou seus dependentes.

b) FRANQUIA é o valor financeiro previamente estabelecido em contrato, até o qual a **CONTRATADA** não tem responsabilidade de cobertura, tanto para reembolso, quanto para o pagamento à rede própria, credenciada ou referenciada.

10.9.2. COPARTICIPAÇÃO sobre internações psiquiátricas

Ficam as partes cientes que **para todo e qualquer plano da CONTRATADA que envolva cobertura hospitalar, previsto(s) no presente INSTRUMENTO, será pago pela CONTRATANTE, a título de COPARTICIPAÇÃO, o percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre o custo total das internações psiquiátricas, a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de internação, ininterruptos ou não, a cada ano de CONTRATO.**

10.9.3. O pagamento da coparticipação pela **CONTRATANTE** deverá ser realizado no percentual e no limite máximo de cobrança previstos neste **INSTRUMENTO** ou **TABELA DE VENDAS** ou **PROPOSTA COMERCIAL/CONTRATAÇÃO** ou **Condições do(s) Produto(s)** ou **ADITIVO**, que são parte integrante e indissolúvel do presente **INSTRUMENTO** e assinados pelas Partes.

10.9.3.1. As Partes esclarecem que a coparticipação é devida individualmente por cada consulta (eletiva ou urgência/emergência), exames (simples e complexos), sessões e terapias (simples e complexas), incluindo, mas não se limitando, a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo de transtornos globais do desenvolvimento, compreendendo ainda métodos e técnicas de transtorno do espectro autista.

10.9.4. Os valores a título de franquia e coparticipação serão anualmente reajustados de acordo com a data base e percentual aplicado às contraprestações pecuniárias mensais. Estes pagamentos serão efetuados por meios eletrônicos disponibilizados pela **CONTRATADA** quando forem realizados na rede própria.

10.9.4.1. As porcentagens estabelecidas no **CONTRATO** para a coparticipação incidirão sobre os valores dos procedimentos pelo código TUSS previstos na Tabela Referência de Procedimentos e Coparticipação. A Tabela Referência será reajustada conforme variação da experiência de custo assistencial da **CONTRATADA**.

10.9.5. Estabelecem as Partes que será devida a franquia e/ou coparticipação nas hipóteses em que a **CONTRATADA**, por mera liberalidade, vier a autorizar procedimentos não compreendidos nas coberturas previstas no presente **INSTRUMENTO**, como, por exemplo, o home-care, assim entendidas as internações domiciliares, seja em substituição de internações hospitalares convencionais ou não.

10.10. Não Comparecimento em Consultas na Rede Própria (“No show”)

10.10.1. Fica estabelecido que na hipótese de não comparecimento do **Beneficiário** nas consultas agendadas na Rede Própria da **CONTRATADA**, sem que ele desmarque com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, será cobrado à título de multa pelo não comparecimento por consulta o valor descrito conforme material disponível no site da **CONTRATADA** e nos demais canais de atendimento informados no referido site.

10.10.2. A cobrança prevista no item imediatamente anterior ocorrerá a partir do 3º (terceiro) não comparecimento do **Beneficiário** às consultas agendadas na Rede Própria da **CONTRATADA** por ano/vigência do **CONTRATO**.

11. FORMAÇÃO DE PREÇO E MENSALIDADE

11.1. Anualmente, antes do envio do comunicado de reajuste para a **CONTRATANTE**, a **CONTRATADA** analisará o perfil da massa coberta, inicialmente apresentado na **PROPOSTA COMERCIAL**, atualizado de acordo com a composição da massa no momento sinalizado. Nesta análise, uma vez que a massa apresente alteração significativa em qualquer de suas variáveis sejam elas: **a)** distribuição etária; **b)** distribuição

geográfica; **c)** distribuição por sexo; **d)** distribuição por titularidade e **e)** idade média da população atendida; estas alterações poderão ensejar, por parte da **CONTRATADA**, a revisão dos custos iniciais apresentados e que uma vez revistos servirão de base para a aplicação dos reajustes contratualmente previstos neste **INSTRUMENTO**.

11.2. O pagamento das contraprestações pecuniárias à **CONTRATADA** será de responsabilidade da **CONTRATANTE**, independentemente do adimplemento de seus **Beneficiários**.

11.3. O valor da contraprestação pelos serviços prestados deverá ser pago conforme vencimento determinado.

11.4. O regime de pagamento de cada produto será aquele constante na respectiva **Condições do Produto**.

11.5. Em caso de inadimplência dos **Beneficiários** junto à **CONTRATANTE**, esta se responsabilizará integralmente pelo custeio das mensalidades, sendo vedado à **CONTRATADA** cobrar os valores diretamente dos **Beneficiários**.

11.6. A **CONTRATADA** desenvolveu o processo eletrônico de cobrança, visando minimizar os impactos ambientais e conceder aos seus clientes maior agilidade e segurança no recebimento das faturas mensais.

11.6.1. Por meio do presente **INSTRUMENTO**, a **CONTRATANTE** autoriza a **CONTRATADA**, a disponibilizar eletronicamente no site da **CONTRATADA**, no link “Acesso Rápido”/ “Boleto Empresa”, os boletos dos pagamentos mensais, e no link “Acesso Rápido”/ “Troca de Arquivo”, o Demonstrativo das Faturas.

11.6.2. O documento de cobrança será disponibilizado no site da **CONTRATADA** sempre em tempo hábil ao pagamento, nos moldes acordados no presente **INSTRUMENTO**. Na hipótese de indisponibilidade do sistema, deverá o cliente contatar imediatamente seu Gerente de Relacionamento.

11.6.3. Fica autorizada, ainda, a **CONTRATADA** a enviar mensagem de texto e e-mail alertando que a fatura do mês já se encontra disponível no site para emissão e pagamento. A **CONTRATANTE** fica ciente de que o envio da mensagem de texto e e-mail será feito para o número e endereço eletrônico informados na proposta contratual.

11.7. Se houver atraso no pagamento da mensalidade, coparticipação e franquia, o valor a ser pago pela **CONTRATANTE** será acrescido do percentual de juros de 1% (um por cento) ao mês e à multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito em atraso, sem prejuízo da correção monetária, podendo a **CONTRATADA** cobrar outros encargos decorrentes da mora, como custos administrativos e/ou honorários de cobrança, se for o caso, não podendo ultrapassar a 10% (dez por cento) do valor principal (pro rata die), ficando a **CONTRATANTE** ciente de que seu nome poderá ser inscrito no órgãos de proteção ao crédito, nos termos da legislação vigente.

11.8. O valor da mensalidade devida pela **CONTRATANTE** será calculado com base no(s) produto(s) escolhido(s), levando-se em consideração o número de **Beneficiários** participantes da contratação, de acordo com a **TABELA DE PREÇOS** e planos escolhidos.

11.9. O pagamento deverá ser efetuado no dia de vencimento conforme marcação na **PROPOSTA COMERCIAL**.

11.10. Não haverá distinção quanto ao valor da contraprestação pecuniária entre os **Beneficiários Ativos** que vierem a ser incluídos no **CONTRATO** e aqueles a este já vinculados, conforme regulamentação vigente da ANS, ressalvadas as condições de variações do valor da contraprestação pecuniária em razão de mudança de faixa etária, migração e adaptação de contrato à Lei nº 9.656/98

11.11. Não haverá distinção quanto ao valor da contraprestação pecuniária entre os **Beneficiários Inativos** que vierem a ser incluídos no **CONTRATO** e aqueles a este já vinculados, ressalvadas as condições de variações do valor da contraprestação pecuniária em razão de mudança de faixa etária, migração e adaptação de contrato à Lei nº 9.656/98, tudo em conformidade com a RN 488/2022

12. REAJUSTE ANUAL

12.1. Conforme disposto na regulamentação vigente da ANS, é obrigatório às operadoras de planos privados de assistência à saúde formar um agrupamento com todos os seus contratos coletivos com menos de 30 (trinta) beneficiários, para o cálculo do percentual de reajuste que será aplicado a esse agrupamento, com exceção dos contratos exclusivamente odontológicos e contratos exclusivos para **Beneficiários Inativos**.

12.2. Os contratos inseridos no agrupamento que trata o item acima terão o valor das mensalidades e da tabela de preços para novas adesões reajustados anualmente, com base em um dos itens listados abaixo, o que for maior:

- a) da variação positiva do IGPM (Índice Geral de Preços ao Mercado da Fundação Getúlio Vargas – FGV) apuradas no período dos últimos 12 (doze) meses consecutivos, com o tempo de antecedência de 03(três) meses da aplicação do reajuste, respeitada a data-base de aniversário, considerada esta o mês de assinatura do **CONTRATO**;
- b) pelo último Índice de Reajuste divulgado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS;
- c) pelo Índice de Variação dos Custos Médico-Hospitalares – IVCMH, o qual é composto pela variação dos preços dos Honorários Médicos, das Diárias e Taxas Hospitalares, dos Medicamentos, dos Materiais Hospitalares e Gases Medicinais, das Despesas Gerais de Administração e do impacto de novos impostos e Contribuições Sociais incidentes sobre as operações da **CONTRATADA**.

12.3. Caso seja verificado o desequilíbrio econômico-atuarial da carteira, este **CONTRATO** receberá reajuste por sinistralidade nos termos dos itens abaixo.

12.3.1. O índice de sinistralidade, para efeito da revisão da contraprestação pecuniária mensal, será sempre o resultado da divisão do total da Despesa Assistencial Avisada no período de apuração pelo total da Contraprestação Pecuniária Mensal Líquida cobrada durante o mesmo período.

12.3.2. O desequilíbrio é constatado quando o nível de sinistralidade da carteira ultrapassar a meta de sinistralidade, fixada em 70% (setenta por cento) para os planos de saúde, e de 60% (sessenta por cento) para os planos odontológicos, cuja base é a proporção entre as despesas assistenciais e as receitas diretas da carteira, apuradas no período de 12 meses consecutivos, anteriores à data base de aniversário do **CONTRATO**. Neste caso, para o cálculo do percentual de reajuste será aplicada a seguinte fórmula:

$$R = (S/S_m) - 1$$

Onde: S - Sinistralidade apurada no período (12 meses) na carteira de planos e S_m - Meta de Sinistralidade da carteira expressa em todos os contratos da carteira.

D_m = Total da Despesa Assistencial Avisada com atendimentos previstos neste Contrato, considerando-se para o 1º reajuste, a exclusão dos 03 (três) primeiros meses, dos 12 (doze) meses iniciais de vigência; e

R_i = Total da Contraprestação Pecuniária Mensal Líquida, já deduzidos os impostos e contribuições que incidem sobre o faturamento, considerando-se para o 1º reajuste, a exclusão dos 03 (três) primeiros meses, dos 12 (doze) meses iniciais de vigência.

12.4. Caso seja constatado desequilíbrio econômico-atuarial resultado de alterações no risco assistencial provenientes do aumento do ROL de Procedimentos Obrigatórios publicado pela ANS, das alterações na legislação que incorram em aumento de custos, das alterações na rede de prestadores e das elevações de custos oriundos de decisões do judiciário, o **CONTRATO** poderá ser reajustado, e a metodologia do reajuste, bem como seu impacto, serão divulgados pela **CONTRATADA** por meio de seu site na internet.

12.5. Na hipótese de se constatar a necessidade de aplicação dos reajustes previsto nos itens 12.3 e 12.4, deverão ser procedidos de forma complementar ao especificado no item 12.2 e na mesma data, de forma a garantir a anualidade dos reajustes.

12.6. Os contratos exclusivos de **Beneficiários Inativos**, assim considerados os aposentados ou demitidos/exonerados sem justa causa, em conformidade com o disposto nos artigos 30 e 31, da Lei 9.656/98, e RN 488 da ANS, terão o valor das mensalidades e da tabela de preços para novas adesões reajustados em conformidade com o previsto nos itens abaixo.

12.6.1. Os contratos serão reajustados anualmente, com base em um dos itens listados abaixo, o que for maior:

a) da variação positiva do IGPM (Índice Geral de Preços ao Mercado da Fundação Getúlio Vargas – FGV) apuradas no período dos últimos 12 (doze) meses consecutivos, com o tempo de antecedência de 03(três) meses da aplicação do reajuste, respeitada a data-base de aniversário, considerada esta o mês de assinatura do **CONTRATO**;

b) pelo último Índice de Reajuste divulgado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS;

c) pelo Índice de Variação dos Custos Médico-Hospitalares – IVCMH, o qual é composto pela variação dos preços dos Honorários Médicos, das Diárias e Taxas Hospitalares, dos Medicamentos, dos Materiais Hospitalares e Gases Medicinais, das Despesas Gerais de Administração e do impacto de novos impostos e Contribuições Sociais incidentes sobre as operações da **CONTRATADA**.

12.6.2. Caso seja verificado o desequilíbrio econômico-atuarial da carteira de planos de **Beneficiários Inativos**, este **CONTRATO** receberá reajuste por sinistralidade nos termos dos itens abaixo.

12.6.2.1. O índice de sinistralidade, para efeito da revisão da contraprestação pecuniária mensal, será sempre o resultado da divisão do total da Despesa Assistencial Avisada no período de apuração pelo total da Contraprestação Pecuniária Mensal Líquida cobrada durante o mesmo período.

12.6.2.2. O desequilíbrio é constatado quando o nível de sinistralidade da carteira ultrapassar a meta de sinistralidade, fixada em 60% (sessenta por cento), cuja base é a proporção entre as despesas assistenciais e as receitas diretas da carteira, apuradas no período de 12 meses consecutivos, anteriores à data base de aniversário do contrato. Neste caso, para o cálculo do percentual de reajuste será aplicada a seguinte fórmula:

$$R = (S/S_m) - 1$$

Onde: S - Sinistralidade apurada no período (12 meses) na carteira de planos exclusivos de **Inativos**; e Sm - Meta de Sinistralidade da carteira expressa em todos os contratos da carteira.

D_m = Total da Despesa Assistencial Avisada com atendimentos previstos neste Contrato, considerando-se para o 1º reajuste, a exclusão dos 03 (três) primeiros meses, dos 12 (doze) meses iniciais de vigência; e

R_i = Total da Contraprestação Pecuniária Mensal Líquida, já deduzidos os impostos e contribuições que incidem sobre o faturamento, considerando-se para o 1º reajuste, a exclusão dos 03 (três) primeiros meses, dos 12 (doze) meses iniciais de vigência.

12.6.3. Caso seja constatado desequilíbrio econômico-atuarial resultado de alterações no risco assistencial provenientes do aumento do ROL de Procedimentos Obrigatórios publicado pela ANS, das alterações na legislação que incorram em aumento de custos, das alterações na rede de prestadores e das elevações de custos oriundos de decisões do judiciário, o contrato poderá ser reajustado, e seu impacto será comunicado pela **CONTRATADA**.

12.6.4. Na hipótese de se constatar a necessidade de aplicação dos reajustes previsto nos itens 12.6.2 e 12.6.3, deverão ser procedidos de forma complementar ao especificado no item 12.6.1 e na mesma data, de forma a garantir a anualidade dos reajustes.

12.7. Os percentuais de reajustes aplicados aos contratos citados nos itens 12.2, 12.3 e 12.6 são independentes entre si.

12.8. Nenhum contrato poderá receber reajuste em periodicidade inferior a 12 meses, ressalvadas as variações do valor da contraprestação pecuniária em razão de mudança de faixa etária. Caso a legislação venha a permitir reajustes em prazo inferior a 01 (um) ano, o reajuste financeiro será automaticamente aplicado ao presente instrumento, na menor periodicidade admitida.

12.9. Independentemente da data de inclusão dos **Beneficiários**, os valores de suas contraprestações terão o primeiro reajuste integral na data de aniversário de vigência deste Instrumento, entendendo-se esta como data base única.

12.9. Reajuste por Faixa Etária e suas variações

12.9.1. O percentual de reajuste por mudança de faixa etária, quando houver previsão, seguirá os percentuais dispostos na **TABELA DE PREÇOS** acima apresentada e será aplicado no mês imediatamente posterior ao aniversário do **Beneficiário** que mudar de uma faixa etária para a outra.

13. PAD (PROGRAMA DE APOSENTADOS E DEMITIDOS) – REGRAS

13.1. Nos contratos de planos coletivos empresariais, o direito de permanência no plano aos demitidos ou exonerados sem justa causa e aposentados que contribuírem para o plano, conforme disposto nos artigos 30 e 31, da Lei nº 9.656/1998, serão observados de acordo com a Regulamentação vigente, bem como, de acordo com as seguintes disposições:

13.1.1. O **Beneficiário Titular, DEMITIDO OU EXONERADO SEM JUSTA CAUSA** ou **APOSENTADO**, deverá manifestar sua opção junto à **CONTRATADA**, em até 30 (trinta) dias da data da comunicação inequívoca do empregador sobre a manutenção da condição de beneficiário de que gozava quando da vigência do contrato

de trabalho, formalizada no ato da concessão do aviso prévio, a ser cumprido ou indenizado, ou da comunicação da aposentadoria.

13.1.2. Ao empregado **APOSENTADO** que continua trabalhando na mesma empresa e vem a se desligar, é garantido o direito de manter sua condição de beneficiário aposentado e será exercido pelo ex-empregado aposentado no momento do desligamento junto ao empregador. Essa condição é garantida aos dependentes do empregado aposentado que continuou trabalhando na mesma empresa e veio a falecer antes do exercício do direito previsto no artigo 31, da Lei nº 9.656/98.

13.2. O período de manutenção da condição de beneficiário (artigo 30, § 1º, e artigo 31, caput e § 1º, da Lei nº 9656/1998) será:

13.2.1. Aos **Beneficiários Titulares** com vínculo empregatício com a **CONTRATANTE**, que tenham contribuído no pagamento da taxa de manutenção mensal de Plano Privado de Assistência à Saúde coletivo empresarial, desligado do quadro de pessoal da **CONTRATANTE**, por haverem sido **DEMITIDOS OU EXONERADOS SEM JUSTA CAUSA**, é assegurado o direito de manutenção, como **Beneficiário**, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozavam quando da vigência do Contrato de Trabalho, desde que assumam o pagamento integral do seu plano e de seus dependentes que se encontravam regularmente inscritos no plano oferecido pelo empregador, quando da vigência do contrato de trabalho do **Beneficiário Titular Ativo**. A manutenção da condição, ora aludida, está vinculada aos seguintes prazos, de acordo com a regulamentação vigente:

a) um terço (1/3) do tempo de permanência em que tenha contribuído para o Plano, ou seus sucessores, sendo assegurado ao **Beneficiário**, um período mínimo de seis (06) meses e máximo de vinte e quatro (24) meses.

13.2.2. Aos **Beneficiários Titulares** com vínculo empregatício com a **CONTRATANTE**, que tenham contribuído no pagamento da taxa de manutenção mensal de Plano Privado de Assistência à Saúde coletivo empresarial, desligado do quadro de pessoal da **CONTRATANTE**, por haverem adquirido direito à **APOSENTADORIA**, é assegurado o direito de manutenção, como **Beneficiário**, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozavam quando da vigência do Contrato de Trabalho, desde que assumam o pagamento integral do seu plano e de seus dependentes que se encontravam regularmente inscritos no plano oferecido pelo empregador, quando da vigência do contrato de trabalho do **Beneficiário Titular Ativo**. A manutenção da condição, ora aludida, está vinculada aos seguintes prazos, de acordo com a regulamentação vigente:

- a) Se o aposentado contribuiu para o plano por período igual ou superior a 10 (dez) anos, terá o direito de manter sua condição de beneficiário, juntamente com seus dependentes, por prazo indeterminado;
- b) Se o aposentado contribuiu para o mesmo plano ou seu sucessor, por período inferior a 10 (dez) anos, terá o direito de manter as condições de beneficiário, juntamente com seus dependentes, à razão de 01 (um) ano para cada ano de contribuição.

13.3. Em caso de morte do **Beneficiário Titular** durante o gozo dos benefícios previstos nos casos de **DEMISSÃO OU EXONERAÇÃO SEM JUSTA CAUSA** e **APOSENTADORIA**, os seus dependentes cobertos pelo plano terão direito de permanência, durante os períodos fixados e mediante o pagamento da respectiva taxa de manutenção mensal.

13.4. O direito assegurado nesta cláusula aos **DEMITIDOS SEM JUSTA CAUSA** ou **APOSENTADOS** não exclui vantagens obtidas pelos empregados decorrentes de negociações coletivas de trabalho.

13.5. O direito assegurado se extingue e a exclusão dos **Beneficiários Inativos** dar-se-á, automaticamente, na ocorrência de qualquer das hipóteses abaixo:

- a) Pelo decurso do prazo de manutenção;
- b) Pela admissão do **Beneficiário** em novo emprego;
- c) Pelo cancelamento, pela **CONTRATANTE**, do Plano Privado de Assistência à Saúde que concede este benefício a seus empregados ativos e ex-empregados.

13.5.1. O **Beneficiário Titular** e seus dependentes que estejam em gozo do benefício previsto nos arts. 30 e 31, da Lei nº 9.656/98, independente de notificação prévia, terão atendimento suspenso se alguma mensalidade permanecer sem quitação total por período superior à 5 (cinco) dias contados do seu vencimento, assim como serão excluídos do **CONTRATO** no caso de inadimplemento conforme previsto na cláusula 15.4, sem prejuízo da cobrança das mensalidades em aberto pela **CONTRATADA**, independentemente da adimplência da **CONTRATANTE** em relação aos contratos dos **Ativos** e da adimplência dos demais **Inativos**.

13.6. Nos planos custeados integralmente pela **CONTRATANTE**, o **Beneficiário Titular**, DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA ou EXONERADO, não fará jus ao direito previsto nos arts. 30 e 31, da Lei nº 9.656/98. Não é considerada contribuição, os valores relacionados aos dependentes e agregados e a coparticipação ou franquia paga, única e exclusivamente em procedimentos, como fator de moderação, na utilização dos serviços de assistência médica, se for o caso.

13.6.1. Entende-se por contribuição, qualquer valor pago pelo empregado, inclusive com desconto em folha de pagamento, para custear parte ou a integralidade da contraprestação pecuniária de seu plano privado de assistência à saúde oferecido pelo empregador em decorrência de vínculo empregatício, à exceção dos valores relacionados aos dependentes e agregados e à coparticipação ou franquia paga única e exclusivamente em procedimentos, como fator de moderação, na utilização dos serviços de assistência médica.

13.7. Será disponibilizado plano de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de **Beneficiários**, no caso de cancelamento do contrato coletivo, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência, desde que o **Beneficiário** faça opção pelo produto individual ou familiar equivalente, no prazo máximo de trinta dias após o cancelamento (CONSU Nº. 19/99). O valor da mensalidade corresponderá ao valor da Tabela Vigente na data de adesão ao plano Individual/familiar.

13.8. Os ex-empregados demitidos ou exonerados sem justa causa ou aposentados ou seus dependentes vinculados ao plano, durante o período de manutenção da condição de **Beneficiário** garantida pelos artigos 30 e 31, da Lei No. 9.656/98, poderá exercer a portabilidade especial de carências para plano individual ou familiar ou coletivo por adesão em outra operadora.

13.9. Na eventualidade da sucessão de planos, ou seja, quando um **Beneficiário** tiver contribuído para planos de outras operadoras, lhe será assegurado o direito à extensão, desde que não tenha havido descontinuidade na contribuição, com base no período total de contribuição e não apenas em função do tempo de contribuição aos planos da contratada.

13.9.1. Para o exercício do direito do enunciado deste item, o **Beneficiário** deverá fazer prova mediante documentação comprobatória da aludida contribuição.

13.9.2. Quando vier de operadora anterior na condição de extensão, seja por demissão ou aposentadoria, o **Beneficiário** deverá trazer a documentação comprobatória da operadora anterior em que conste o início do gozo do benefício, a data prevista para o término, os **Beneficiários Dependentes** já presentes no contrato anterior bem como os comprovantes de que se encontra adimplente com os pagamentos nos últimos 90 (noventa) dias. Esta documentação deverá ser entregue nas unidades administrativas da **CONTRATADA** e outros documentos complementares poderão ser requisitados para comprovar adequadamente a condição.

14. DA DURAÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO

14.1. Este **INSTRUMENTO** tem prazo de vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data referida na **PROPOSTA COMERCIAL**, sendo renovado automaticamente por prazo indeterminado, caso não haja manifestação contrária das partes.

15. DA SUSPENSÃO E DA RESCISÃO CONTRATUAL

15.1. O **CONTRATO** poderá ser **SUSPENSO**, a qualquer tempo, após 5 (cinco) dias de atraso no pagamento da fatura ou por esta não ter sido integralmente liquidada, até a quitação do valor total da obrigação, sem prejuízo da cobrança integral das mensalidades, independentemente de notificação prévia por parte da **CONTRATADA**.

15.2. As causas que autorizam a **RESCISÃO** unilateral do **CONTRATO** pela **CONTRATADA** são:

- a)** A qualquer tempo, por inadimplência superior a 30 (trinta) dias de atraso no pagamento da fatura, ainda que esta tenha sido parcialmente liquidada, sem prejuízo da cobrança integral das mensalidades em aberto, mediante notificação prévia à **CONTRATANTE**, informando que, em caso de não pagamento, o **CONTRATO** será rescindido na data indicada na referida notificação;
- b)** A qualquer tempo, por total esvaziamento de **Beneficiários** do **CONTRATO**, pela **CONTRATANTE**, por mais de 90 (noventa) dias consecutivos, independente de notificação prévia;
- c)** No aniversário do **CONTRATO**, por ilegitimidade da **CONTRATANTE** em relação à sua qualidade de **EMPRESÁRIO INDIVIDUAL, caso assim seja constituído(a)**, e/ou por descumprimento dos requisitos de elegibilidade dos **Beneficiários** vinculados ao **CONTRATO**, mediante notificação prévia de 60(sessenta) dias, informando que a rescisão será realizada se não for comprovada, neste prazo, a sua regularidade junto à Receita Federal e à Junta Comercial do respectivo Estado/Órgão Competente, bem como o vínculo empregatício dos seus empregados e de parentesco entre estes e seus dependentes, por meio da documentação prevista no item 4.3.3, da cláusula 4, do presente **INSTRUMENTO**, nos termos da regulamentação vigente da ANS.

15.3. O **CONTRATO** poderá ser rescindido imotivadamente, por qualquer uma das partes, após decorrido o prazo de vigência inicial, mediante prévia notificação da outra parte, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.

15.3.1. Se a **CONTRATANTE** for constituída como **EMPRESÁRIO INDIVIDUAL**, nos termos da regulamentação vigente da ANS, a rescisão contratual na forma prevista no item 15.3, somente poderá ocorrer no aniversário do **CONTRATO**.

15.3.2. Nos casos em que a **CONTRATANTE** desejar rescindir o **CONTRATO** antes de completada a vigência inicial, haverá multa rescisória no valor igual à média das 03 (três) últimas faturas imediatamente anteriores à rescisão.

15.3.2.1. O **CONTRATO** poderá ser rescindido motivadamente pela **CONTRATADA**, quando da ocorrência de esvaziamento de **Beneficiários**, seja total ou em quantidade de vidas abaixo do número mínimo estabelecido neste **INSTRUMENTO**, durante a vigência inicial ou após a sua renovação, sem prejuízo da cobrança da multa rescisória prevista no item imediatamente anterior e das demais penalidades previstas neste **CONTRATO** para a hipótese de rescisão.

15.4. Se a **CONTRATANTE** for constituída como **EMPRESÁRIO INDIVIDUAL**, nos termos da regulamentação vigente da ANS, ou no caso de **Beneficiário** que efetuar pagamento das mensalidades diretamente à **CONTRATADA**, a rescisão ou exclusão contratual por inadimplência, somente poderão ocorrer quando do atraso no pagamento de 2 (duas) mensalidades, consecutivas ou não, mediante prévia notificação, a ser realizada pelos seguintes meios:

- a) correio eletrônico (e-mail) com certificado digital ou com confirmação de leitura;
- b) mensagem de texto para telefones celulares via SMS ou via aplicativo de mensagens com criptografia de ponta a ponta;
- c) ligação telefônica gravada, de forma pessoal ou pelo sistema URA (unidade de resposta audível), com confirmação de dados pelo interlocutor;
- d) carta, com aviso de recebimento (AR) dos correios, não sendo necessária a assinatura da pessoa natural a ser notificada; ou;
- e) preposto da **CONTRATADA**, com comprovante de recebimento assinado pela pessoa natural a ser notificada.

15.4.1. A notificação será considerada válida e surtirá todos os efeitos legais quando utilizadas as informações cadastradas no banco de dados da **CONTRATADA**, sendo de responsabilidade integral e exclusiva do **CONTRATANTE** e do **Beneficiário** mantê-las atualizadas.

15.4.2. A **CONTRATANTE** dá anuência para exclusão do **Beneficiário** inadimplente nos termos deste **INSTRUMENTO**.

15.4.3. De forma complementar aos meios dispostos nesta cláusula, a notificação por inadimplência poderá ser feita em área restrita da página institucional da **CONTRATADA** na Internet e/ou por meio de aplicativo da **CONTRATADA** para dispositivos móveis.

15.4.4. As regras previstas nesta cláusula prevalecerão onde conflitarem com outros instrumentos.

16. DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1. Ressarcimento ao SUS:

Para efeito do disposto no artigo 32 da Lei nº 9.656/98 que institui o Ressarcimento ao Sistema Único de Saúde - SUS como sendo a obrigação de ressarcir ao erário público valores relativos aos atendimentos de **Beneficiários** de operadoras privadas de planos de assistência à saúde prestados pela rede pública de saúde vinculada ao SUS, a **CONTRATANTE** reconhece que estes atendimentos não são orientados pela

CONTRATADA e ocorrem da busca direta dos próprios **Beneficiários** nas situações que assim entenderem como adequadas.

A obrigação de ressarcir tais valores recai sobre a **CONTRATADA**, mas decorre da utilização dos **Beneficiários** da **CONTRATANTE**, sendo que esta reconhece que, uma vez que o(s) procedimento(s) tenham cobertura prevista nos instrumentos contratuais de cada um dos planos/produtos integrantes do presente **INSTRUMENTO**, estes valores fazem parte dos custos assistenciais e serão utilizados no cálculo da sinistralidade prevista para efeitos dos reajustes e lançados na utilização dos respectivos **Beneficiários** tendo o SUS como seu prestador atrelado.

Caso a cobrança se refira à procedimentos não cobertos ou não devidos, a **CONTRATADA** se encarregará de fazer a sua defesa administrativa no sentido de não ressarcir indevidamente nenhum valor.

16.2. Responsabilidade das partes:

16.2.1. As partes se isentam mutuamente de quaisquer responsabilidades de natureza civil, criminal ou trabalhista por quaisquer eventos à que não tenham dado causa.

16.2.2. Da mesma forma, cada uma das partes, responde isoladamente pelos aspectos financeiros e tributários decorrentes do presente **CONTRATO** no tocante aos recolhimentos de tributos, contribuições e demais obrigações fazendárias.

16.2.3. O presente **CONTRATO** implica em exclusividade da contratação de planos de saúde pela **CONTRATANTE** perante a **CONTRATADA**, ficando impedida de contratar livremente com outras operadoras de planos privados de assistência à saúde durante a sua vigência.

16.2.4. As Partes reconhecem e declaram que não existe e não se estabelecerá qualquer vínculo empregatício entre qualquer delas e os profissionais que a outra utilizar na execução dos serviços objeto deste instrumento que, por sua vez, não gera nenhuma forma de responsabilidade subsidiária ou solidária entre uma parte e os profissionais da outra, sendo cada uma delas responsável, individualmente, pelo cumprimento das normas da legislação trabalhista, tributária, previdenciária, assistencial e securitária, decorrentes de suas respectivas atividades.

16.3. Assunção pela CONTRATANTE do custo de liminares para procedimentos não cobertos pela CONTRATADA

16.3.1. Visando resguardar o objeto da presente contratação, que define as condições e a abrangência de cobertura dos planos contratados, bem como resguardar o equilíbrio econômico-financeiro do **CONTRATO** e a continuidade da garantia dos serviços, fica o **CONTRATANTE** ciente de que arcará financeiramente com todos os custos relativos aos procedimentos que a **CONTRATADA** for compelida a realizar, por força de medida judicial e/ou administrativa, aos quais o **Beneficiário** não tenha direito, por não serem de cobertura obrigatória.

16.3.2. Na hipótese prevista no item anterior, serão aplicados os mesmos mecanismos de regulação e suas particularidades estabelecidos neste **CONTRATO**, inclusive os financeiros, conforme os valores previstos em tabela que poderá ser consultada por meio dos canais de atendimento da **CONTRATADA**, valores estes que serão atualizados anualmente.

16.3.3. A **CONTRATANTE** autoriza desde já a **CONTRATADA**, a tão logo realizado o procedimento a que foi compelida a executar, a emitir fatura complementar para que a **CONTRATANTE** arque com o pagamento das devidas despesas, a título de custo operacional, ou ainda, a critério exclusivo da **CONTRATADA**, alocá-las junto às despesas assistenciais do **CONTRATO** (reversão para sinistro).

16.3.4. O evento que for quitado pela **CONTRATANTE** não será considerado para fins de cálculo da sinistralidade do **CONTRATO**.

16.4. Responsabilidade solidária da CONTRATANTE e respeito às normas da ANS:

Ao firmar o presente **INSTRUMENTO**, a **CONTRATANTE** se obriga solidariamente ao cumprimento dos dispositivos que ensejem obrigações definidos na Lei nº 9.656/98 e legislação complementar, como por exemplo, comunicações aos **Beneficiários**, fornecimento de orientações, documentos e informações à **CONTRATADA**, quando assim requisitados etc.

16.5. Qualquer concessão praticada pela **CONTRATADA** no tocante às cláusulas do presente **CONTRATO**, será tida como mera liberalidade, não se constituindo em novação contratual, bem como não se caracterizando direito adquirido pela **CONTRATANTE** e/ou **Beneficiários**, permitindo à operadora retornar ao que está pactuado neste **CONTRATO**, sem necessidade de comunicação prévia.

16.6. A tolerância ou demora da **CONTRATADA** em exigir do **CONTRATANTE** o cumprimento de quaisquer das obrigações aqui previstas não será considerado novação, podendo, conforme o caso, a qualquer tempo, ser exigido seu cumprimento.

16.7. O **CONTRATANTE** declara-se expressamente ciente que os serviços e coberturas disciplinados nesta contratação, estão submetidos a exclusões, limitações de coberturas e abrangências, prazos, carências e regras que disciplinam o seu fornecimento, tais como as expostas nas cláusulas deste **INSTRUMENTO**. Admite, outrossim, que a **CONTRATADA** dispõe de outros planos de assistência à saúde, com coberturas mais amplas e preços diferenciados, que lhe foram oferecidos por esta última e, ainda assim, reafirma seu interesse na contratação aqui estipulada, nas bases descritas no presente instrumento.

16.8. Fazem parte do presente **INSTRUMENTO** todos os documentos entregues ao **CONTRATANTE**, tais como: Proposta Comercial, Proposta de Adesão a Planos de Assistência à Saúde Coletivos (quando for o caso), Declaração de Saúde, Carta de Orientação ao Beneficiário, o Manual de Orientação para Contratação de Planos de Saúde - MPS e Guia de Leitura Contratual - GLC, todos entregues ao **CONTRATANTE** no momento da contratação.

16.9. Para esclarecimentos, sugestões e reclamações, sendo que neste caso é imperativo que seja identificado de forma clara o local, a hora e a data da ocorrência, quanto aos planos contratados, os **Beneficiários** deverão fazê-los por meio do Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC (Fone nº. 0800 409 1750) ou da Ouvidoria (Fone nº. 0300 774 9221) da **CONTRATADA**. Os casos omissos no presente **INSTRUMENTO** serão resolvidos de comum acordo entre as **CONTRATANTE**.

16.10. O **CONTRATO** está de acordo com as determinações da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS e encontra-se registrado nos Cartórios de Registro de Títulos e Documentos de Pessoas Jurídicas informados na página de Apresentação de Produtos, da **Proposta de Adesão** firmada pela **CONTRATANTE**.

16.11. Em todas as hipóteses de reembolso das despesas médico-hospitalares previstas no presente **CONTRATO** e/ou na(s) **Condições do(s) Produto(s)** contratado(s) poderá a **CONTRATADA** exigir, além da documentação elencada, todos e quaisquer comprovantes para que seja demonstrado de maneira inequívoca que o pagamento se deu às expensas do **Beneficiário** para o prestador de serviços médico-hospitalares, desde a origem dos valores até o efetivo pagamento, incluindo, mas não a estes limitados, comprovante de transferência ou depósito bancário, comprovante de PIX ou de compensação de cheque, fatura de cartões de crédito, extratos bancários, dentre outros.

16.12. Este presente **CONTRATO** poderá ser composto de um ou mais “Aditivos” contratuais, nos quais constarão informações adicionais, bem como especificações e particularidades dos serviços a serem prestados.

17. DA POLÍTICA DE PROTEÇÃO DOS DADOS

17.1. Caso, em virtude deste **CONTRATO**, as Partes tenham acesso a dados pessoais, sensíveis ou não, de clientes, colaboradores, prestadores de serviços, acionistas ou outras pessoas físicas da **CONTRATANTE**, as Partes, além das obrigações previstas neste instrumento, comprometem-se a:

- (i) Cumprir a Lei nº 13.709/18 e legislação relacionada à proteção de dados pessoais e privacidade (“LGPD”);
- (ii) Realizar o tratamento dos dados única e exclusivamente para o cumprimento do objeto do presente **CONTRATO**;
- (iii) Após o término da finalidade, as informações recebidas deverão ser excluídas ou apagadas de forma definitiva, em atendimento à LGPD;
- (iv) Somente deverão ter acesso aos dados pessoais aqueles colaboradores que realmente necessitam destas informações para a prestação dos serviços objeto do presente instrumento;
- (v) Tomar as medidas de segurança de informação necessárias para a proteção dos dados, evitando o compartilhamento ou o vazamento dos dados pessoais, sensíveis ou não, compartilhados sob a égide deste **CONTRATO**;
- (vi) Responder integralmente pelos danos causados à Parte inocente por violação de dados ou vazamento de informações, objeto deste **CONTRATO**;
- (vii) Manter a Parte inocente livre de qualquer reclamação, ação ou questionamento em função do uso indevido dos dados pessoais, ora revelados, incluindo utilização fora da finalidade descrita aqui e demais utilizações em desacordo com o expressamente previsto neste **INSTRUMENTO**.

17.2. Segurança no tratamento dos dados

Considerando as técnicas mais avançadas, os custos de aplicação e a natureza, o âmbito, o contexto e as finalidades do tratamento de dados, bem como os riscos, de probabilidade e gravidade variável, para os direitos e liberdades das pessoas singulares, as Partes deverão aplicar as medidas técnicas e organizativas adequadas para assegurar um nível de segurança adequado ao risco.

17.3 Violação de dados pessoais

Em caso de violação de dados pessoais, perda de arquivos ou na ocorrência de qualquer incidente de segurança ou vulnerabilidade constatada na sua rede, envolvendo os dados, a Parte infratora deverá comunicar por escrito, em até 2 (dois) dias úteis contados da descoberta da referida violação ou evento a outra Parte, essa notificação deverá conter os dados completos relativos ao evento.

17.4 Auditoria

Fica desde já autorizado pelas Partes a realização de auditorias, conforme aplicável, a fim de verificar o cumprimento do disposto neste **CONTRATO**, bem como, na ocorrência do disposto dos itens acima, para avaliar a extensão da violação, incidente ou evento de violação de dados ocorridos.

18. LEI ANTICORRUPÇÃO E LAVAGEM DE DINHEIRO

18.1. As Partes desde já ficam cientes de que o relacionamento do Grupo Hapvida NotreDame Intermédica com seus fornecedores, parceiros e clientes é pautado em suas políticas aplicáveis à relação contratual, bem como no Código de Conduta e no Programa de Integridade e Compliance disponibilizados nos sites: www.hapvida.com.br/site/integridade-e-compliance e <https://ri.hapvida.com.br/governanca-corporativa/estatuto-e-politicas/>, sendo certo que qualquer prática contrária aos seus conteúdos ou se constatada a participação ou concorrência da Contraparte ou de qualquer de seus representantes para configuração de infração, em especial nas hipóteses de corrupção previstas na legislação vigente na data do evento, notadamente na Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013) e na Lei Contra a Lavagem de Dinheiro (Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998), parcialmente reformada pela Lei nº 12.683 de 2012, mas sem se limitar a elas, será considerada nula para todos os fins e efeitos, ensejando a rescisão motivada e imediata do presente instrumento, independentemente de qualquer notificação, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste Contrato e da apuração de eventuais perdas e danos. Em caso de denúncias relacionadas a violação de leis, regulamentos e/ou políticas do Grupo Hapvida NotreDame Intermédica, a comunicação poderá ocorrer pelo canal de denúncias independente, de forma anônima, por meio do site www.canaldedenuncias.com.br/hapvidandi/ ou pelo telefone 0800 591 5126. Fica ainda disponível para dirimir dúvidas e inconformidades o e-mail integridade@hapvida.com.br.

19. DA RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

19.1. As Partes comprometem-se a:

- a)** respeitar e fazer cumprir todas as disposições da legislação ambiental vigente, responsabilizando-se perante a outra parte, os Órgãos Ambientais e à Sociedade, por todo e qualquer dano ou prejuízo que porventura causar ao meio ambiente, bem como a executar seus serviços respeitando os atos legais, normativos, administrativos e correlatos, emanados das esferas Federal, Estaduais e Municipais, incluindo, mas não limitando ao cumprimento da Lei Federal nº 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente), da Lei nº 9.605/98 (Lei dos Crimes Ambientais) e da Lei nº 12.305/10 Política Nacional de Resíduos Sólidos implementando ainda esforços nesse sentido junto aos seus respectivos colaboradores de produtos e serviços, a fim de que esses também se comprometam a conjugar esforços para proteger e preservar o meio ambiente, bem como a se prevenir contra práticas danosas a este;
- (b)** não empregar trabalhadores menores de dezesesseis anos de idade, salvo na condição de aprendiz a partir de quatorze anos, nos termos da Lei nº 10.097 de 19.12.2000 e da Consolidação das Leis do Trabalho e demais legislações que regem a matéria.
- (c)** não empregar adolescentes até 18 anos de idade, em locais prejudiciais à sua formação, ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social, bem como em locais e serviços perigosos ou insalubres, em horários que não permitam a frequência à escola e, ainda, em horário noturno, de acordo com a legislação específica;
- (d)** não adotar práticas de trabalho análogo ao escravo e trabalho ilegal de crianças e adolescentes no cumprimento do presente **CONTRATO**;
- (e)** combater à prática de discriminação em todas as suas formas;
- (f)** valorizar a diversidade em seus locais de trabalho, promovendo a equidade;

- (g) prevenir o assédio moral e sexual;
- (h) combater a exploração sexual de crianças e adolescentes em suas operações e na sua cadeia de suprimento;
- (i) realizar o pagamento pontual e correto de suas obrigações com a Receita Federal, a previdência social e demais obrigações tributárias;
- (j) cumprir as condições de saúde e segurança previstas por lei aos colaboradores.

20. DA CONFIDENCIALIDADE

20.1. A PARTE RECEPTORA compromete-se expressamente a não fornecer a terceiros e a manter em estrito sigilo as informações deste **CONTRATO**, bem como se compromete a não as utilizar, exceto no que concerne ao desenvolvimento dos objetivos e prestações de serviços deste **CONTRATO**. Na hipótese de violação da presente cláusula, a PARTE RECEPTORA estará sujeita a indenizar a PARTE DIVULGADORA por quaisquer prejuízos que venha a suportar.

20.2. Entende-se por informações confidenciais, neste **CONTRATO**, todos os dados que não sejam de domínio público, reveladas pela PARTE DIVULGADORA à PARTE RECEPTORA, com referência aos seus negócios ou a assuntos de seus interesses, inclusive, mas sem limitação, todas as informações financeiras, operacionais, técnicas ou mercadológicas, bem como aquelas informações originadas durante a prestação do serviço e que constituam propriedade e/ou posse da PARTE DIVULGADORA.

20.3. Toda a base de dados gerada, compartilhada ou disponibilizada entre as partes em virtude do serviço contratado, serão considerados confidenciais em caráter irrevelável e irretratável, e sobreviverão de modo permanente após o respectivo término da vigência deste **CONTRATO**.

20.4. A PARTE RECEPTORA poderá fazer uso das informações disponibilizadas pela PARTE DIVULGADORA, somente para os propósitos da prestação de serviço, formalizada em **CONTRATO**, estando proibida a utilização para fins pessoais ou de outras empresas, sob pena da rescisão contratual e penalidades previstas no **CONTRATO**, respondendo pelas perdas e danos incorridos.

20.5. A PARTE RECEPTORA reconhece expressamente que a divulgação de qualquer informação a que tenha tido acesso, com violação das obrigações aqui assumidas, importa na prática de crimes previstos nos artigos 153 e 154 do Código Penal e na Lei nº 9.279, de 14.05.96, bem como na prática de ilícito civil, ensejando ação de perdas e danos.

20.6. O não cumprimento por parte da PARTE RECEPTORA da obrigação da confidencialidade aqui prevista, ou por parte de qualquer de suas sócias, associadas, funcionárias, prepostas, agentes, ou representantes, eximirá a PARTE DIVULGADORA do cumprimento de suas obrigações, inclusive pecuniárias, nos termos dos artigos 476 e 477 do Código Civil, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.

20.7. A PARTE RECEPTORA constitui-se na obrigação de, ao término do **CONTRATO**, seja qual for o motivo, devolver à PARTE REVELADORA todos os dados, relatórios, documentos, instruções, processos ou elementos de qualquer natureza que tenha recebido para o cumprimento de suas atividades e obrigações.

20.8. As obrigações contraídas pela assinatura do **CONTRATO** subsistirão não só durante a sua vigência, mas também após o seu término, de modo permanente.

21. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

21.1. De parte a parte, em razão do **CONTRATO** ora celebrado cumprem:

- a)** respeitar as Políticas, Normas e Procedimentos de Segurança, aplicações ou dados. Garantir que o ambiente de Tecnologia da Informação, em seu lado, assegure a integridade, disponibilidade e confidencialidade do patrimônio de Tecnologia da Informação, incluindo dados, informações e direitos de propriedade intelectual;
- b)** sendo a tecnologia evolutiva, reservam-se ao direito de solicitar o preenchimento de questionários de segurança e/ou relatórios sobre os mecanismos de segurança necessários para a proteção da confidencialidade, integridade e disponibilidade dos produtos e serviços escopo deste **CONTRATO**;
- c)** comunicar e solicitar aprovação a respeito de qualquer alteração ou atualização no modelo de comunicação de dados entre as Partes, mudanças significativas na arquitetura e em configurações de segurança;
- d)** comunicar em até 72 (setenta e duas) horas a outra Parte sempre que for identificado um incidente de segurança associado ao serviço prestado e as informações sob custódia da que sofrer o incidente;
- e)** deverão fornecer um canal de comunicação direto para tratamento aos eventos que envolvam incidentes de segurança cibernética;
- f)** em caso de rescisão do **CONTRATO**, todas as informações custodiadas de uma parte a outra, deverão ser devolvidas e removidas da infraestrutura da de forma segura, tais como: tecnologia *Enhanced Secure Erase* (preferencialmente) ou a tecnologia *Secure Erase*, ou outra tecnologia de *WIPE* similar que torne as informações irrecuperáveis;
- g)** reparar, corrigir ou substituir imediatamente, às suas expensas, no total ou em parte do objeto deste **CONTRATO**, quando se identificarem riscos ou vulnerabilidades ou incorreções resultantes da execução, sem custo adicional da **CONTRATANTE**;
- h)** poderão a qualquer momento, editar cláusulas de Segurança da Informação estipuladas, na forma pactuada neste **CONTRATO** para adequação dos serviços ou atendimento das normas dos reguladores ou adequações às práticas de segurança;
- i)** responsabilizar-se pelos comprovados atos e omissões praticados por seus empregados e/ou contratados, bem como, mas não se limitando a quebra de sigilo das informações confidenciais da **CONTRATANTE** e/ou pelos danos que estes comprovadamente venham causar para a PARTE PREJUDICADA.

22. DECLARAÇÕES DO CONTRATANTE

A **CONTRATANTE** declara para os devidos fins, inclusive os de direito, que recebeu no ato da celebração do presente **INSTRUMENTO**, todos os documentos entregues ao **CONTRATANTE**, tais como: **Condições do(s) Produto(s)**, Proposta de Adesão, Declaração de Saúde (quando houver), a Carta de Orientação ao Beneficiário, os Manuais de Orientação para Contratação de Planos de Saúde - MPS e os Guias de Leitura Contratual - GLC.

23. DA EXTENSÃO DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS

23.1. A **CONTRATANTE** poderá estender as condições contratuais estabelecidas no presente **CONTRATO** a outras empresas interessadas e a ela comprovadamente vinculadas, desde que haja concordância da **CONTRATADA**, por meio de aditivo específico.

24. FORO E ASSINATURAS

As partes elegem o Foro da Comarca em que se encontra estabelecido a **CONTRATANTE** para dirimir os possíveis questionamentos oriundos da relação contratual estabelecida no presente **INSTRUMENTO**.

Como alternativa à assinatura física do **INSTRUMENTO**, as Partes declaram e concordam que a assinatura mencionada poderá ser efetuada em formato eletrônico. As Partes reconhecem a veracidade, autenticidade, integridade, validade e eficácia deste Instrumento e seus termos, incluindo seus anexos, nos termos do art. 219 do Código Civil, em formato eletrônico e/ou assinado pelas Partes por meio de certificados eletrônicos, ainda que sejam certificados eletrônicos não emitidos pela ICP-Brasil, nos termos do art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 (“MP nº 2.200-2”).

As Partes declaram, sob as penas da Lei, que os signatários do presente instrumento são seus legítimos diretores/administradores/procuradores/representantes legais, devidamente constituídos na forma dos respectivos Estatutos/Contratos Sociais, com poderes para assumir e cumprir todas as obrigações ora contraídas.

E, assim, por estarem concordes nos termos acima, as partes, por meio de seus representantes legais, firmam o presente **INSTRUMENTO**, por meio da assinatura da respectiva **PROPOSTA COMERCIAL** de PLANO COLETIVO EMPRESARIAL.

APARECIDA DE GOIANI

Local

08 / 07 / 2026

Data

CONTRATANTE

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
(CNPJ: 63.554.067/0001-98)
CONTRATADA

Testemunhas:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:



BENEFICIÁRIOS COM TERMO DE RESPONSABILIDADE FINANCEIRO - CONTRATO COLETIVO
Hapvida Assistência Médica SA • Av Heráclito Graça, 406. Centro. Fortaleza/CE • CEP 60140-060

Nº DA PROPOSTA

958843

01 - Dados da Empresa Contratante

DR MARMORES E GRANITOS LTDA, pessoa jurídica de direito
privado, legalmente inscrita sob o CNPJ nº. 66.693.135/0001-98, estabelecida na Av/Rua X 42,
Nº 0, complemento, bairro SETOR TOCANTINS, na cidade APARECIDA DE GOIANIA, estado
GO, neste ato representada pelo Sr. (a) CAIO DUARTE DE SOUSA FREITAS, portador do CPF nº. 070.515.742-10

02 - Declaração da Empresa Contratante

A contratante declara junto à Hapvida Assistência Médica S.A. que se responsabiliza pelo pagamento da fatura dos relacionados abaixo, os quais estão aderindo ao seu plano de assistência médica e/ou odontológico.

03 - Documentos Solicitados

Status	Ficha Proposta / Aditivo	Contrato Social	CNPJ
--------	--------------------------	-----------------	------

04 - Relação de Usuários Cadastrados e Documentos Vinculados

CPF	Nome Titular / Dependente / Agregado / Prest. Serviço	Tipo	Dt Nascimento	Estado Civil	Nome da mãe	Num Reg ANS	Valor	Carência
070.515.743-10	CAIO DUARTE DE SOUSA FREITAS	T	24/07/1996	CASADO	MARIA FIDELIS DE SOUSA DUARTE	487815209	R\$ 242,67	N
061.397.273-24	RENATA RODRIGUES DE SOUSA	D	20/05/1996	CASADO	ANTONIA MARINALVA ALVES RODRIGUES	487815209	R\$ 242,67	N
062.718.201-15	RUAN ASAPH DE SOUSA DUARTE	D	15/03/2024	SOLTEIRO	RENATA RODRIGUES DE SOUSA	487815209	R\$ 168,22	N
039.727.421-18	ROBERTO CARLOS MACHADO SILVA	T	24/06/1990	CASADO	MARIA AUZAIR MACHADO	487815209	R\$ 279,07	N
702.880.551-44	KAREN CRISTINA PEREIRA CAVALCANTE	D	11/04/1996	CASADO	CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS	487815209	R\$ 242,67	N
108.826.561-80	CARLOS ALEJANDRO CAVALCANTE MACHADO	D	13/09/2020	SOLTEIRO	KKAREN CRISTINA PEREIRA CAVALCANTE	487815209	R\$ 168,22	N

* Estado Civil: S - Solteiro / C - Casado / V - Viúvo / D - Divorciado / O - Outros

** Classificação: T - Titular / D - Dependente

ANS nº 368253



BENEFICIÁRIOS COM TERMO DE RESPONSABILIDADE FINANCEIRO - CONTRATO COLETIVO
Hapvida Assistência Médica SA • Av Heráclito Graça, 406. Centro. Fortaleza/CE • CEP 60140-060

Nº DA PROPOSTA

958843

04 - Relação de Usuários Cadastrados e Documentos Vinculados (continuação)

* Estado Civil: S - Solteiro / C - Casado / V - Viúvo / D - Divorciado / O - Outros

** Classificação: T - Titular / D - Dependente

Por ser expressão da verdade assina,a presente relação para que surta seus devidos efeitos legais.

APARECIDA DE GOIANIA, 08 / 07 / 2026
Local Data

Assinatura do Contratante ou Responsável Legal

TOTAL GERAL R\$ 1.603,02

ANS nº 368253

Os principais pontos do seu contrato

estão aqui

Listamos as maiores dúvidas para que você consiga entender o seu contrato:

1. Carência

2. Doença ou Lesão Preexistente - DLP

3. Cobertura Parcial Temporária - CPT

4. Reajustes

5. Coparticipação

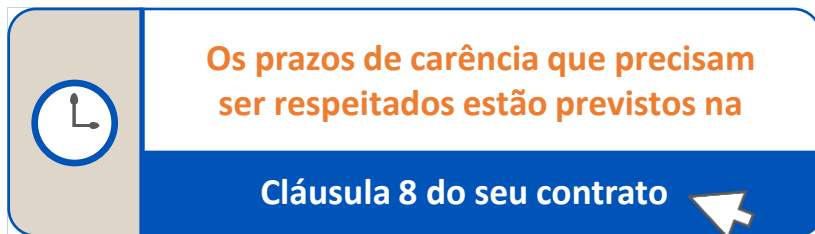
6. Suspensão e Cancelamento

CONTRATO DE PLANOS DE
ASSISTÊNCIA À SAÚDE
COLETIVO EMPRESARIAL



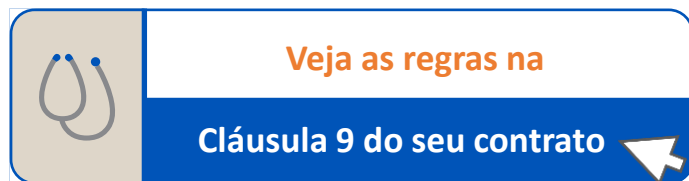
1. Carência

Carência é o **período** em que você paga a mensalidade, mas ainda não tem acesso a determinadas coberturas.



2. Doença ou Lesão Preexistente - DLP

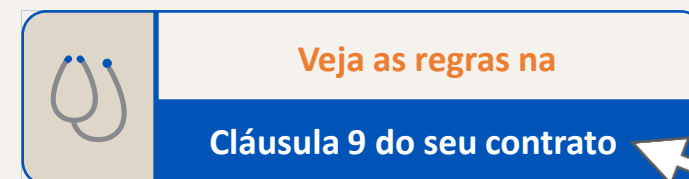
Ao contratar um plano, se exigido o preenchimento da **Declaração de Saúde**, informe à operadora a doença ou lesão que saiba ser portador – com relação a si e a todos os dependentes integrantes de seu contrato.



3. Cobertura Parcial Temporária - CPT

Você não terá cobertura para os seguintes procedimentos relacionados à DLP pelo prazo de 24 meses: **eventos cirúrgicos, leitos de alta tecnologia e procedimentos de alta complexidade.**

Os demais procedimentos para as doenças ou lesões preexistentes (consultas e diversos exames) serão cobertos pela operadora, de acordo com o tipo de plano contratado, após o cumprimento dos prazos de carência.



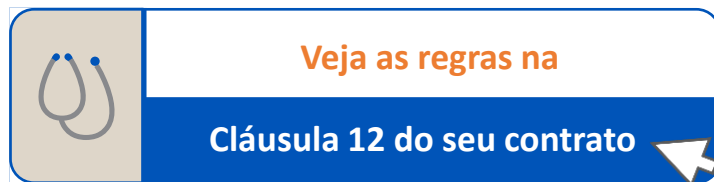
4. Reajustes

- **Menos de 30 vidas:** reajuste único aplicável a todos os contratos da operadora.
- **30 vidas ou mais:** o reajuste será negociado de acordo com o contrato.

4.1. Reajuste Financeiro

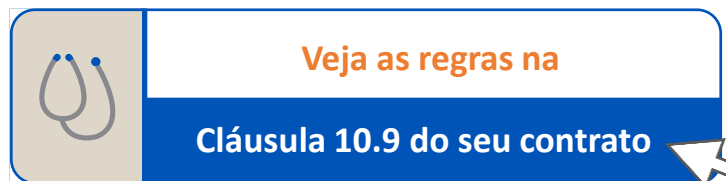
4.2. Reajuste por Sinistralidade

4.3. Mudança de Faixa Etária



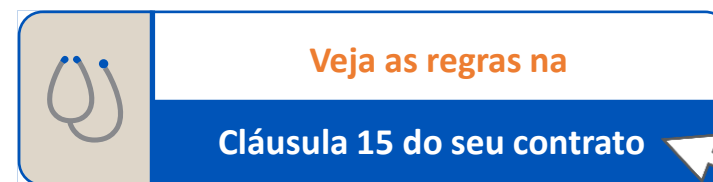
5. Coparticipação

Coparticipação é o valor pago por você para custear uma parte do procedimento a ser realizado.



6. Suspensão e Cancelamento

- **Suspensão:** após 5 dias de atraso no pagamento.
- **Cancelamento:**
 - a) após 30 dias de atraso no pagamento;
 - b) após cumprir o aviso prévio de 60 dias;
 - c) multa antes da vigência inicial.



Todas as demais condições estão no seu contrato.
Caso tenha dúvida, acesse nosso FAQ
escaneando o QR Code ao lado.





Conecte-se conosco:

www.hapvida.com.br

 [/hapvida.saude](https://www.facebook.com/hapvida.saude)

 [@hapvidasaude](https://twitter.com/hapvidasaude)

SAC: 0800 280 9130